



Nuansa
Fajar
Cemerlang

KEBUGARAN TUBUH MANUSIA PENTING DALAM MEMPERTAHANKAN KELENTURAN TUBUH LANSIA

Jacoba Nugrahaningtyas Wahjuning Utami • Sukmawati
Maratusholikhah Nurtyas



KEBUGARAN TUBUH MANUSIA: PENTING DALAM MEMPERTAHANKAN KELENTURAN TUBUH LANSIA

Penulis:

dr. Jacoba Nugrahaningtyas Wahjuning Utami, M.Kes.

Sukmawati, S.Si.T., M.Kes.

Maratusholikhah Nurtyas, S.ST., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Kebugaran Tubuh Manusia: Penting dalam mempertahankan Kelenturan Tubuh Lansia

Penulis: dr. Jacoba Nugrahaningtyas Wahjuning Utami, M.Kes
Sukmawati, S.Si.T., M.Kes
Maratusholikhah Nurtyas, S.ST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7097-67-5

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Kebugaran tubuh manusia : penting dalam mempertahankan kelenturan tubuh lansia / penulis, dr. Jacoba Nugrahaningtyas Wahjuning Utami, M.Kes., Sukmawati, S.Si.T., M.Kes., Maratusholikhah Nurtyas, S.ST., M.Kes.

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
vi, 87 halaman ; 30 cm
ISBN 978-634-7097-67-5

Kesehatan

613 [23]

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1182466>

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul **"Kebugaran Tubuh Manusia: Penting untuk Mempertahankan Kelenturan Tubuh Lansia"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai referensi yang komprehensif, membahas aspek kebugaran tubuh manusia dalam berbagai tahapan kehidupan, mulai dari masa remaja hingga lanjut usia, dengan fokus pada pentingnya kelenturan tubuh sebagai bagian dari kesehatan holistik.

Isi buku ini meliputi tiga bab utama. Bab pertama membahas hubungan antara masa remaja dan kebugaran, termasuk prinsip-prinsip serta manfaat kebugaran yang berkelanjutan hingga usia lanjut. Bab kedua mengupas peran kelenturan tubuh bagi lansia dan dampaknya terhadap kualitas hidup serta kemampuan fisik di usia tua. Bab ketiga berfokus pada pentingnya gizi yang tepat untuk mendukung kebugaran tubuh pada lansia, menguraikan bagaimana pola makan yang sehat dapat memperlambat proses penuaan dan mempertahankan vitalitas.

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan dan aplikatif bagi berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi kesehatan, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh. Dengan menyajikan topik yang mudah dipahami, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan buku ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para ahli dan teman-teman peneliti yang menjadi referensi utama, serta kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga selama proses penulisan serta PT. Nuansa Fajar Cemerlang yang memfasilitasi sehingga buku ini selesai.

Harapan kami, buku ini dapat memotivasi pembaca untuk lebih memperhatikan kesehatan tubuh, khususnya dalam menjaga kebugaran dan kelenturan tubuh di setiap fase kehidupan. Kami percaya bahwa investasi pada kesehatan tubuh adalah kunci untuk menjalani hidup yang berkualitas, produktif, dan bahagia.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Selamat membaca, dan mari bersama-sama menjaga kesehatan tubuh untuk kehidupan yang lebih baik.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 AKTIVITAS FISIK DAN KELENTURAN TUBUH LANSIA	3
--	----------

- A. Aktivitas Fisik dan kelenturan..... 4
- B. Hubungan aktivitas fisik dengan kelenturan tubuh..... 13
- C. Dampak gangguan kelenturan terhadap kehidupan lansia
15
- D. Latihan Untuk Mempertahankan kelenturan tubuh 17

BAB 3 KESEHATAN REMAJA DAN KEBUGARAN	21
---	-----------

- A. Kesehatan Remaja dan Kebugaran..... 21
- B. Tujuan Kesehatan Remaja dan Kebugaran 24
- C. Manfaat Kesehatan Remaja dan Kebugaran 28
- D. Bentuk Kesehatan Remaja dan Kebugaran 30
- E. Prinsip-prinsip Kesehatan Remaja dan Kebugaran..... 33
- F. Ruang Lingkup Kesehatan Remaja dan Kebugaran 35
- G. Intervensi Kesehatan Remaja dan Kebugaran..... 38
- H. Dampak Kesehatan Remaja dan Kebugaran saat Lansia .. 42

BAB 4 GIZI PADA MASA LANJUT USIA (LANSIA)	47
--	-----------

- A. Pengertian Lanjut Usia (Lansia)..... 47
- B. Perubahan pada Lansia 48
- C. Status Gizi Lansia..... 52
- D. Penilaian Status Gizi Lansia 53
- E. Masalah Gizi Lansia 54
- F. Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi 56

G. Asupan Gizi Untuk Lansia	60
H. Prinsip Kebutuhan Gizi Lansia	61
I. Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Gizi Pada Lansia	64

BAB 5 PENUTUP.....69

DAFTAR PUSTAKA.....71

GLOSARIUM79

PROFIL PENULIS83

BAB 1

PENDAHULUAN

Kebugaran seseorang sangat dibutuhkan dalam mempertahankan kualitas hidup seseorang. Kebugaran secara fungsional adalah kapasitas fisik optimal yang diperlukan untuk melanjutkan aktivitas normal sehari-hari, secara mandiri dan tanpa timbulnya kelelahan dini. Kebugaran secara fungsional bergantung pada gaya hidup, tingkat aktivitas fisik dan status Kesehatan. Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi otot skeletal yang membutuhkan energi dan menghasilkan manfaat kesehatan secara menyeluruh

Aktivitas fisik sangat dibutuhkan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan aktivitas fisik ini dari bayi baru lahir hingga usia lanjut (lansia). Aktivitas fisik untuk lansia perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lansia. Lansia adalah tahap akhir siklus hidup manusia, merupakan bagian dari proses kehidupan yang tak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Agar tetap bugar maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga asupan gizi. Aktivitas fisik merupakan faktor penting dalam kebugaran jasmani, faktor makanan juga berpengaruh pada kebugaran jasmani. Sehingga dengan asupan gizi yang cukup akan dapat mempengaruhi kebugaran pada tubuh.

Kebugaran lansia tentunya tidak lepas dari perilaku sehat yang dilakukan sejak usia remaja. Kesehatan pada remaja merupakan bidang kesehatan yang unik yang perlu diperhatikan. Remaja merupakan generasi muda yang dapat

terpapar berbagai faktor yang berdampak negatif pada kesehatannya. Beberapa masalah kesehatan yang sering dialami remaja di Indonesia di antaranya: Anemia, Kurang tinggi badan (stunting), Kurang energi kronis (kurus), Kegemukan atau obesitas

Usia Remaja merupakan masa perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Perilaku kesehatan pada remaja tentunya akan memberikan dampak pada kesehatan pada lansia. Apabila usia remaja tidak memperhatikan kesehatan maka gangguan jangka panjang yang akan muncul terutama pada lansia. Salah satu gangguan pada lansia adalah terjadinya kekakuan otot dan tulang yang rapuh. Gangguan kesehatan pada lansia yang sering dijumpai adalah gangguan kelenturan tubuh.

Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis potensi perlunya menjaga kesehatan sejak usia remaja dan berperilaku hidup sehat sejak remaja serta menjaga keseimbangan gizi sehingga lansia sehingga kesehatan lansia terjaga dan kelenturan tubuh menjadi lebih terjaga

Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif tentang perlunya menjaga kebugaran dan kesehatan sejak usia remaja serta menjaga keseimbangan gizi hingga lansia maka lansia akan hidup tanpa gangguan kesehatan.

BAB 2

AKTIVITAS FISIK DAN KELENTURAN TUBUH LANSIA

WHO mendefinikan aktivitas fisik sebagai Gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan energi. Aktivitas fisik yang sering dijumpai antara lain berjalan kaki, bersepeda, rekreasi, berolah raga, bermain dan dapat dilakukan pada tingkat keterampilan apa pun dan untuk kesenangan semua orang. selain itu WHO (2024) juga menyampaikan bahwa aktivitas fisik bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan. Namun apabila ada ketidakaktifan fisik akan meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) dan memiliki dampak kesehatan buruk lainnya. Dengan kata lain apabila tubuh tidak melakukan aktifitas fisik, dan diikuti perilaku tidak aktif maka akan memiliki potensi terhadap peningkatan PTM dan membebani sistem perawatan kesehatan.

Tingkat aktivitas fisik biasanya menurun seiring pertambahan usia dan dikaitkan dengan penurunan kebugaran fungsional, dan pada akhirnya akan menurunkan kebugaran fungsional lansia baik laki-laki maupun perempuan. Kebugaran fisik yang berhubungan dengan keterampilan terdiri dari beberapa komponen, yaitu kelincahan (agility), keseimbangan, koordinasi, waktu reaksi, kecepatan dan daya ledak otot. Sedangkan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan Kesehatan terdiri dari ketahanan kardiorespirasi, kekuatan dan daya tahan otot, serta kelenturan otot (W. Hoeger et al., 2019; Purwantini dan Lestariana, 2024)

Kelenturan merupakan kemampuan untuk menggerakkan persendian dengan maksimal guna untuk mengurangi resiko cidera disebut dengan daya lentur atau kelenturan. Dengan kata lain, daya lentur atau kelenturan adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan tubuhnya kepada tiap-tiap aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara melakukan penguluran tubuh dengan baik (Kemenkes, 2020).

Dengan peregangan maka dapat menghindari timbulnya cidera di bagian sendi dan otot. Meningkatkan kemampuan kelenturan di seluruh tubuh sehingga bisa membuat persendian bergerak dengan bebas, lancar, serta bisa meminimalisir adanya gangguan-gangguan seperti keseleo atau terkilir terutama pada lansia (Ashwini, Neha dan Lata, 2021)

A. Aktivitas Fisik dan kelenturan

1. Aktivitas fisik

Menurut Kemenkes (2020) aktivitas fisik mencakup aktivitas yang dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga/rumah tangga, aktivitas selama dalam perjalanan dan aktivitas lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari.

Aktivitas fisik yang direkomendasikan WHO (2024) merekomendasikan aktivitas fisik diperuntukkan anak-anak (usia 5 tahun ke atas), remaja, dewasa, lansia, ibu hamil dan pascapersalinan, serta orang yang hidup dengan kondisi kronis dan disabilitas. Selain itu WHO juga menekankan bahwa berapa pun jumlah aktivitas fisik lebih baik daripada tidak sama sekali; semua aktivitas fisik diperhitungkan; semua kelompok usia harus membatasi jumlah waktu untuk sedenter dan penguatan otot bermanfaat bagi semua orang.

Kelompok usia lansia memberikan gambaran yang nyata untuk penurunan aktivitas fisik. Sehingga kelompok

lansia memerlukan pendampingan dan konsultasi aktivitas fisik agar tubuh tetap bugar.

Selain itu Kemenkes (2018) juga menyatakan bahwa pada lansia Aktivitas Fisik Untuk Lansia dianjurkan dengan durasi minimal 150 menit untuk latihan fisik sedang atau 17 menit untuk latihan fisik berat dalam waktu seminggu. Selain itu perlu dipastikan bahwa pada lansia durasi aktivitas fisik minimal adalah 10 menit.

Selain itu Kemenkes (2018) apabila lansia sudah sering melakukan aktivitas selama 10 menit maka dapat dianjurkan untuk membiasakan meningkatkan dengan aktivitas sedang. Aktivitas sedang ini dilakukan selama 300 menit dalam seminggu atau dapat melakukan aktivitas berat selama 150 menit dalam seminggunya.

Kemenkes (2018) juga menyatakan bahwa sebagian besar lansia mempunyai kendala dalam koordinasi tubuh, sehingga membutuhkan sesi latihan keseimbangan minimal tiga kali seminggu, sedangkan untuk latihan otot minimal dua kali seminggu.

Jenis olahraga atau aktivitas fisik untuk lansia yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk intensitas sedang, misalnya, jalan kaki jarak dekat, membersihkan rumah, bersepeda santai, naik tangga, hingga berkebun. Sedangkan aktivitas berat meliputi berenang, tai chi, yoga, jogging, jalan cepat, menggendong anak, sampai bulu tangkis (Kemenkes 2018)

2. Manfaat melakukan aktivitas fisik

Tanpa disadari bahwa aktivitas fisik memiliki banyak manfaat. Berdasarkan golongan kelompok usia maka pada anak-anak dan remaja dapat terjadi peningkatan kebugaran fisik, kesehatan kardiometabolik, kesehatan

tulang, hasil kognitif, kesehatan mental dan pengurangan lemak tubuh.

Kelompok usia dewasa dan orang lanjut usia dapat mengurangi risiko kematian karena sebab apa pun, risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular, hipertensi, kanker spesifik lokasi, diabetes tipe-2, dan resiko jatuh, serta meningkatkan kesehatan mental, kesehatan kognitif, tidur, dan pengukuran lemak tubuh (WHO, 2024)

Lansia perlu aktif secara fisik karena hal ini memberikan manfaat segera dan jangka panjang pada kesehatan lansia baik secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Manfaat secara fisik yang bersifat segera diantaranya mengatur kadar gula darah, meningkatkan hormon-hormon yang memberikan rasa bersemangat, serta dapat meningkatkan kualitas tidur. Efek jangka panjang bagi lansia dari segi fisik adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, menjaga kelenturan tubuh lansia,serta mencegah atau menunda munculnya gangguan koordinasi dan keseimbangan akibat penuaan (Kemenkes 2024)

Untuk Ibu hamil dan pasca-persalinan dapat terjadi penurunan risiko preeklamsia, hipertensi gestasional, diabetes gestasional, penambahan berat badan gestasional yang berlebihan, komplikasi persalinan, depresi pasca-persalinan, dan komplikasi pada bayi baru lahir. Aktivitas fisik tidak memiliki efek buruk pada berat badan lahir atau peningkatan risiko lahir mati.

Perilaku sedentary adalah periode pengeluaran energi rendah saat terjaga seperti duduk, berbaring, atau berbaring. Kehidupan menjadi semakin sedentary melalui penggunaan transportasi bermotor dan meningkatnya penggunaan layar untuk bekerja, belajar, dan rekreasi.

Bukti menunjukkan bahwa perilaku sedentary yang lebih tinggi dikaitkan dengan dampak kesehatan yang buruk berikut: pada anak-anak dan remaja, peningkatan adipositas, kesehatan kardiometabolik, kebugaran, dan perilaku/perilaku pro-sosial yang lebih buruk, dan berkurangnya durasi tidur (Ferdiana, 2023)

Pada orang dewasa, meningkatnya angka kematian karena semua penyebab, angka kematian akibat penyakit kardiovaskular, dan angka kematian akibat kanker, serta kejadian penyakit kardiovaskular, kanker, dan diabetes tipe-2.

Gangguan kelenturan dapat dikarenakan kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan pemendekan otot, yang mengakibatkan penurunan kelenturan dan keterbatasan rentang gerak atau mobilitas sendi. selain itu gangguan kelenturan juga diakibatkan berkurangnya masa otot (Ashwini, Neha dan Lata, 2021).

3. Pendampingan Keluarga untuk Aktivitas fisik pada lansia

Pendampingan lansia merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka. Dengan makin bertambahnya usia, lansia membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan mereka tetap sehat dan bahagia. Kondisi fisik pun menjadi makin menurun, yang berdampak pada aktivitas sehari-hari (Kemenkes,2020)

Selain itu Kemenkes (2020) juga menyampaikan bahwa secara alamiah perubahan yang di alami lansia seperti penurunan aktivitas fisik, kulit mulai keriput, pendengaran berkurang, penglihatan mulai kabur, mudah lelah, gigi mulai pada tanggal dan penurunan/perubahan

lainnya. Tentunya setiap lansia akan berbeda kondisinya, tidak setiap lansia mengalami hal tadi secara bersamaan di usia tertentu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup dan pola makan ketika masih usia muda, beberapa lansia masih terlihat bugar, penglihatan dan pendengaran yang baik termasuk aktivitas fisik yang masih tetap dilakukan seperti ketika masih usia muda. Tetapi, pada lansia lainnya tidak hanya perubahan/penurunan secara alamiah, dengan berbagai penyakit tertentu yang dideritanya lansia tersebut terlihat lebih menderita dan tidak bisa menikmati masa tua secara berkualitas.

Dalam pendampingan lansia ini diperlukan hal-hal yang positif untuk meningkatkan kesehatan lansia. Dari mulai menu makan, aktivitas fisik, pemeriksaan rutin, hingga lingkungan pendukunPendampingan pada lansia yang berkaitan dengan kesehatan tentunya sangat dibutuhkan lansia. Pendampingan ini dapat membantu lansia untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki kebugaran fisik, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam konseling dan pendampingan aktivitas fisik pada lansia: Mengidentifikasi kebutuhan lansia, seperti pola hidup sehat, nutrisi, hidrasi, manajemen stres, dan pentingnya tidur; Merencanakan aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan lansia; melaksanakan aktivitas fisik yang telah direncanakan; mengevaluasi aktivitas fisik yang telah dilaksanakan.

Pendampingan kepada lansia baik pada saat pelaksanaan kegiatan maupun pelaksanaan aktivitas fisik telah selesai dapat memberikan dampak pada lansia berupa lansia dapat mengenal faktor resiko penyebab

gangguan kelenturan tubuh pada lansia. (Kosuke and Masatoshi, 2020).

BKKBN (2024) menyatakan meskipun angka harapan hidup meningkat atau lebih panjang, tetapi kalau dalam kondisi tidak baik malah justru akan menurunkan kualitas hidup lansia tersebut. Merawat lansia tidak semudah yang orang bayangkan, karena tidak hanya perubahan fisik saja, tapi ada perubahan-perubahan lain seperti emosional, psikologis maupun mental lansia. Keberadaan lansia di suatu keluarga tidak semua bisa dilayani atau dirawat dengan baik, beberapa keluarga bahkan harus mempekerjakan asisten rumah tangga, perawat untuk merawat lansia bahkan tidak sedikit yang menyerahkan lansia tersebut untuk tinggal dan mendapat perawatan di panti jompo atau tempat-tempat lain yang sejenis.

4. Kebutuhan Lansia terhadap komunitas

Menua bukanlah suatu penyakit, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis mengakibatkan perubahan yang bertambah, dan merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan baik dari luar maupun dari dalam dengan berakhirnya dalam kematian (BKKBN, 2024).

BKKBN (2024) juga menyatakan bahwa seiring dengan bertambahnya usia pada Lansia akan timbul beberapa permasalahan dan perubahan serta kebutuhan pada diri Lansia, diantaranya: Perubahan Fisik yang Terjadi Saat Lansia Seiring dengan bertambahnya umur, Lansia akan mengalami banyak perubahan diantaranya perubahan fisik, psikologis, dan sosial.

Perubahan Fisik pada lansia merupakan perubahan yang umum terjadi dan bersifat alamiah. Perubahan fisik

ini adalah menurunkan aktivitas fisik, menurunnya fungsi organ reproduksi, mudah lelah, pendengaran berkurang, penglihatan menurun, rambut memutih, dan keriput. Selain ini perubahan psikologis/mental yang biasa dialami lansia adalah pikun, depresi, ketakutan, susah tidur, dan mudah tersinggung.

Perubahan sosial saat memasuki usia tua dalam perubahan di sosial masyarakat hal yang biasa terjadi pada lansia adalah lansia cenderung suka menyendiri, dan tidak mempunyai gairah untuk berkumpul dengan orang untuk itu kebutuhan teman sebaya. Kebutuhan ini sangat diperlukan terutama dengan hadirnya kerabat, sahabat, teman sebaya (BKKBN, 2024).

Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan bantuan orang lain karena panduan mengalami penurunan kognitif, psikologis lansia juga harus diperhatikan, karena kondisi lansia ini rentan terganggu secara psikologis. Lansia membutuhkan teman yang sabar dan dapat memahami kondisinya. Dukungan keluarga menjadi peran utama dalam masalah ini.

Keterbatasan yang dialami oleh lansia ini dapat mempengaruhi semangat untuk beraktivitas fisik. Sehingga keberadaan teman sebaya dapat memotivasi lansia untuk hidup sehat, mempertahankan kebugaran termasuk menjaga kelenturan tubuh. Selain itu keberadaan teman sebaya bagi lansia dapat memberikan kesempatan bagi lansia untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik, seni, dan budaya. Termasuk olah raga Bersama untuk mempertahankan kelenturan tubuh.

5. Kelenturan dan gangguan kelenturan tubuh

Kelenturan adalah kemampuan otot dan persendian untuk bergerak secara maksimal tanpa gangguan. Faktor-

faktor yang memengaruhi kelenturan adalah keturunan, latihan, pemanasan, dan temperature (Kemenkes, 2020). Selain itu perilaku sedentary merupakan salah satu penyebab menurunnya tingkat kebugaran jasmani yang berdampak pada kelenturan (Ashwini, Neha and Lata, 2021). Factor utama yang memengaruhi kelenturan tubuh adalah usia. Seiring bertambahnya usia maka aktivitas fisik menjadi menurun khususnya latihan yang berfokus pada peregangan dan penguatan. Dengan bertambahnya usia juga menyebabkan penurunan aktivitas fisik pada lansia, adanya penurunan aktivitas fisik ini maka gerakan pada suatu sendi akan berubah berdasarkan penurunan aktivitas fisik tersebut. Selain itu seiring bertambahnya usia, maka penyakit degeneratif pun juga akan muncul. Salah satu penyakit degenerative yang dapat mengganggu kelenturan dan gangguan kelenturan adalah osteoarthritis (Kemenkes, 2020). Selain itu BKKBN (2024) juga menyampaikan bahwa seiring bertambahnya usia, massa otot secara alami menurun dan lansia kehilangan kepadatan tulang, yang menyebabkan berkurangnya kelenturan tubuh. Namun, dengan sering melakukan peregangan dan tetap aktif, kita dapat mengurangi penurunan alami ini dan meningkatkan kelenturan tubuh, mobilitas, dan pergerakan kita secara keseluruhan. Penting untuk secara aktif melatih kelenturan bagi lansia karena kekakuan yang timbul seiring bertambahnya usia bisa sangat membatasi. Ini bukan hanya soal pembatasan pergerakan; itu juga dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Misalnya, kekakuan pada sendi pinggul dan otot terkait (misalnya psoas) dapat menyebabkan panggul miring dan nyeri punggung bagian bawah.

Faktor lain yang memengaruhi kelenturan tersebut adalah sebagai berikut

a. Keturunan

Kelenturan adalah kemampuan otot dan persendian untuk bergerak secara maksimal. Genetic/keturunan memiliki pengaruh pada ukuran dan komposisi otot (persentase serat otot cepat dan lambat). Faktor genetik yang memengaruhi komposisi otot antara lain struktur, tipe, dan bentuk sendi, serta bentuk ligamen dan tendon akan memengaruhi kelenturan tubuh. Faktor-faktor ini bersifat genetik atau keturunan, sehingga sulit diubah sedangkan kekuatan otot terkait erat dengan komposisi serat dengan kata lain factor genetic memiliki efek besar pada kekuatan otot dan persendian

b. Latihan kelenturan adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kelenturan tubuh, yaitu kemampuan untuk menggerakkan tubuh dengan leluasa dan tanpa gangguan. Latihan kelenturan dapat membantu mengurangi rasa sakit saat berolahraga dan mencegah cedera otot.

c. Pemanasan sebelum melakukan latihan kelenturan adalah memiliki tujuan untuk mempersiapkan tubuh agar lebih lentur. Pemanasan yang tepat dapat dilakukan dengan jalan cepat, jogging ringan, atau gerakan dinamis lainnya selama 5–10 menit (kemenkes, 2018)

d. Temperature/Suhu tubuh adalah salah satu faktor yang memengaruhi kelenturan tubuh. Peningkatan suhu tubuh ini melalui peregangan dapat membuat otot lebih fleksibel, sehingga tidak mudah tegang, keseleo, atau robek.

- e. Perilaku sedentary adalah *sedentary behavior* adalah perilaku duduk, berbaring sehari-hari tetapi tidak termasuk waktu tidur, baik di tempat kerja, di rumah atau di perjalanan/transportasi. Contoh *Sedentary behavior* ini adalah: berbaring atau duduk dalam waktu lama, seperti menonton tv, bermain video game, duduk lama di depan komputer, anak-anak pergi ke sekolah dengan diantar menggunakan kendaraan meskipun jaraknya dekat, perubahan kebiasaan misalnya orang pergi ke toko atau mini market hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggalnya menggunakan mobil atau motor. Dengan kata lain, *sedentary behavior* ini adalah gaya hidup orang yang malas/jarang sekali menggerakkan tubuhnya. *Sedentary behavior* dikelompokkan menjadi 3 berdasar lamanya yaitu: *Sedentary behavior* rendah (dilakukan kurang dari 2 jam), *Sedentary behavior* sedang (dilakukan selama 2 -5 jam), *Sedentary behavior* tinggi (dilakukan lebih dari 2 -5 jam) (Ferdiana, 2023)

Gangguan kelenturan tubuh akan terjadi apabila kekuatan otot tidak dilatih untuk mempertahankan kemampuannya dan sendi tidak digunakan secara maksimal. Selain itu gangguan kelenturan juga dipengaruhi oleh usia. Hal ini

B. Hubungan aktivitas fisik dengan kelenturan tubuh

WHO (2024) menyatakan Banyak faktor yang dapat menentukan seberapa aktif seseorang dan tingkat aktivitas fisik secara keseluruhan dalam berbagai kelompok populasi. Faktor-faktor ini dapat dikaitkan dengan faktor penentu sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi individu atau yang lebih luas yang memengaruhi

akses dan peluang untuk beraktivitas dengan cara yang aman dan menyenangkan.

Kelenturan tubuh adalah komponen paling penting dari kebugaran dan kinerja fisik yang mencakup lingkup gerak sendi. Kelenturan tubuh yang baik berkontribusi pada aktivitas kerja dan olahraga. Latihan kelenturan sangat penting untuk menjaga kelenturan yang dapat dikurangi. kelenturan yang baik berkontribusi pada aktivitas fisik dan olahraga (Kosuke and Masatoshi, 2020).

Aktivitas fisik merupakan latihan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kelenturan otot, maka akan memperbaiki postur tubuh. Selain itu panjang tulang punggung, panjang tulang bahu, dan panjang tulang kaki bisa meningkat. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh tingkat kelenturan otot dan persendian. Latihan kelenturan ini ditandai dengan semakin panjang otot yang diukur dan sendi juga semakin jauh membuka atau menekuk (Ashwini, Neha dan Lata, 2021).

Aktivitas fisik juga mempengaruhi terhadap kemampuan gerak tubuh, kemampuan tubuh juga sangat penting pada peran aktifitas sehari-hari. Aktivitas fisik yang dimaksud adalah olah raga peregangan. Peregangan bertujuan untuk merileksasikan otot dan sendi pada tubuh sebelum melakukan olah raga, Peregangan juga dapat meningkatkan kelenturan secara selain itu peregangan juga dapat menurunkan sirkulasi darah sehingga dapat membantu mengendurkan sistem syaraf pada tubuh dan dapat melatih otot agar menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah Lelah. Kelenturan adalah kemampuan jaringan otot yang memanjang sehingga sendi dapat bergerak secara maksimal agar terhindar dari resiko cedera. Cedera dapat kita hindari apabila kita

melakukan peregangan dengan maksimal seperti menarik otot-otot dan sendi (Efendi & Rochmania, 2019).

Dengan memiliki aktivitas fisik yang baik maka kelenturan tubuh akan membaik pula dan kelenturan tubuh yang baik akan mempengaruhi lingkup gerak sendi. contoh tarikan pada suatu jaringan yang kekuatannya melebihi batas kelenturannya, sehingga menimbulkan robekan pada jaringan tersebut. Kelenturan lumbal sendiri dinilai penting dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti memutar badan, mengangkat beban, dan membungkuk (Efendi & Rochmania, 2019). Dengan melakukan aktivitas fisik maka ketegangan otot biasanya terjadi ketika tubuh tidak aktif bergerak, sehingga membuat tubuh jadi kaku dan nyeri. Maka peregangan otot perlu dilakukan para lansia untuk menjaga kelenturan otot guna mengurangi dan menghindari nyeri akibat ketegangan otot.

Menurut BKKBN (2024) menyatakan bahwa lansia yang terbiasa duduk, maupun rebahan, maka atihan kelenturan akan mengurangi risiko low back pain. Menjaga kestabilan tulang dan sendi yang tergerus usia

C. Dampak gangguan kelenturan terhadap kehidupan lansia

Aktivitas fisik yang diwujudkan dalam bentuk olahraga pada lansia merupakan bagian yang erat kaitannya dengan Upaya peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran pada lansia. Seorang lansia yang memiliki aktivitas fisik yang rendah (sedentary) memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap berbagai gangguan kesehatan terlebih gangguan kekuatan otot dan persendian. Aktivitas fisik memiliki peran dalam upaya promotif dan preventif, olahraga juga penting

dalam program terapi dan rehabilitasi berbagai jenis gangguan kesehatan.

Olahraga yang terencana dan terstruktur melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang serta ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang membutuhkan energi untuk mengerjakannya, seperti berjalan, menari, mengasuh cucu

Kelenturan mengacu pada rentang gerak fisiologis sendi, yang sangat penting untuk menyelesaikan gerakan dalam aktivitas sehari-hari. Kelenturan bersifat spesifik pada sendi dan berubah tergantung pada otot yang terlibat, oleh karena itu kelenturan tubuh total tidak dapat ditentukan oleh satu tes. Pada anak-anak dan orang dewasa, kelenturan hamstring yang buruk terkait dengan kesulitan melakukan dan mempertahankan aktivitas motorik sehari-hari, serta cedera muskuloskeletal kronis, postur tubuh postural, dan gangguan gaya berjalan. (Sreejisha and Umme, 2022).

Selain itu aktivitas fisik yang jarang dilakukan oleh lansia selain berdampak pada gangguan kelenturan juga akan memberikan dampak kesehatan yang lain. Dampak positif aktivitas fisik pada lansia antara lain adalah memperpanjang usia, menyehatkan dan memperbaiki daya tahan jantung, otot, tulang, membuat lansia lebih mandiri, mencegah obesitas, mengurangi kecemasan dan depresi, dan memperoleh kepercayaan diri yang lebih tinggi. Sedangkan aktivitas olah raga juga dikatakan dapat menurunkan risiko penyakit diabetes melitus, hipertensi dan penyakit jantung.

Sedangkan gangguan kelenturan pada lansia apabila tidak segera dilakukan evaluasi maka lansia semakin enggan untuk beraktivitas sehari-hari. Dan kekuatan otot semakin

menurun dan persendian semakin sulit di gerakan (Kemenkes. 2020)

Pengetahuan kelenturan pada lansia akan mempengaruhi kehidupan lansia. Kurangnya pengetahuan mengenai latihan kelenturan tubuh yang sesuai dengan yang direkomendasikan juga menjadi salah satu penyebab degradasi dan friksi persendian lansia. Aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, membungkuk, menggapai sesuatu dan sebagainya menjadi terhambat karena penurunan kelenturan pada persendian sehingga membatasi ruang gerak atau mobilitas lansia (Kemenkes, 2024).

Dampak kelenturan yang terjadi pada lansia, apabila tidak diketahui sejak dini tentunya akan menghambat aktivitas sehari-hari pada lansia. Selain itu dengan tidak teratasi gangguan kelenturan ini dapat menyebabkan kepercayaan diri yang meningkat. Penurunan kelenturan sendiri dapat dicegah bahkan diperbaiki atau ditingkatkan melalui latihan sebagaimana yang dinyatakan oleh Garber et al., (2011) dimana latihan memberikan efek yang positif terhadap kesehatan tulang, stabilitas postur, kelenturan dan berbagai gerakan, mempertahankan fungsi kognitif, mengurangi gejala dan perilaku stres serta meningkatkan kontrol pribadi dan efikasi diri. Selain itu menurut Garber et.al (2011) juga menyatakan bahwa kurangnya kelenturan berdampak terhadap penurunan rentang gerak (ROM) persendian dan kehilangan kekuatan yang berimplikasi terhadap mobilitas gerak sendi.

D. Latihan Untuk Mempertahankan kelenturan tubuh

Latihan kelenturan atau peregangan sangat dibutuhkan lansia. Peregangan menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menjaga kelenturan otot para lansia. Ada

beragam manfaat peregangan untuk lansia agar mencapai kualitas hidup yang baik. Peregangan penting dilakukan, karena seiring bertambahnya usia, kelenturan/kelenturan otot akan semakin menurun. Tubuh yang tidak aktif bergerak membuat otot kian kaku dan berkurang kelenturannya. Kekakuan otot yang terjadi bisa meningkatkan risiko radang sendi (arthritis). Selain itu, orang yang berusia 65 tahun ke atas memiliki potensi hilangnya massa otot ketika tidak melakukan peregangan otot secara rutin (BKKBN, 2022)

Manfaat melakukan Latihan kelenturan adalah mengurangi risiko cedera pada persendian dan otot, meningkatkan aliran darah ke otot sehingga otot bisa pulih lebih cepat setelah aktivitas teratur, membantu memperbaiki postur tubuh maupun mengurangi risiko kram otot serta membuat otot lebih santai dan tidak tegang sehingga tidak terlalu sakit saat melakukan aktivitas yang membutuhkan gerakan ekstrim.

Peregangan biasanya dilakukan saat pemanasan untuk meningkatkan suhu tubuh inti. Dengan adanya peningkatan suhu tubuh ini membuat otot lebih fleksibel sehingga tidak mudah tegang, keseleo, atau robek. Dengan Latihan peregangan mengharuskan untuk meningkatkan jangkauan otot, sendi, dan tendon semaksimal mungkin (BKKBN, 2022). Selain itu BKKBN (2022) juga menyatakan bahwa Latihan kelenturan memaksimalkan gerak otot dan sendi sehingga semuanya bekerja dengan seimbang, tidak lagi ada yang sedikit atau berlebihan sehingga peregangan ini yang membantu menjaga postur tubuh agar tetap baik.

Selain itu manfaat melakukan latihan kelenturan adalah panjang tulang punggung, panjang tulang bahu, dan panjang tulang kaki semuanya bisa meningkat dipengaruhi oleh seberapa tingkat kelenturan otot dan persendian.

Latihan kelenturan dapat dilakukan dengan peregangan atau stretching pada leher, bahu, lengan, punggung, panggul, dan tungkai. Ada dua jenis kelenturan, yaitu kelenturan statis dan dinamis. Kelenturan statis adalah latihan kelenturan tanpa pengulangan gerakan, sedangkan kelenturan dinamis adalah latihan kelenturan dengan menggerakkan persendian secara berulang-ulang

Latihan kelenturan dapat dilakukan dengan berbagai gerakan, seperti: peregangan leher, bahu, lengan, punggung, panggul, dan tungkai, bridge with leg reach, gerakan hip flexor, gerakan reclining pigeon.

Menurut BKKBN (2020) agar aktivitas terjaga, setidaknya lansia perlu melakukan latihan peregangan setiap hari dengan durasi 15-30 detik pada setiap bagian tubuh. Gerakan ini bisa dilakukan pengulangan setiap gerakan 3-5 kali.

Kemenkes (2024) mengatakan bahwa dengan Latihan mempertahankan kelenturan tubuh pada lansia dapat menguatkan otot-otot tubuh, sehingga otot tubuh tetap lentur dan terhindar dari penyakit rematik.

Kemenkes (2024) menyatakan bahwa segi rehabilitasi medik, dalam wujud aktivitas fisik yang baik pada lansia adalah diperhatikan frekuensi, intensitas, waktu, dan tipenya. Frekuensi sebaiknya dilakukan 3-5 kali/minggu dengan selang istirahat selama 1 hari dan kemudian dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai toleransi. Kemudian intensitas latihan adalah sedang yakni sampai mencapai 60-70 persen denyut nadi maksimal. Cara sederhana untuk mengetahui batas intensitas latihan adalah dengan melakukan tes bicara. Apabila saat melakukan latihan, kata-kata diucapkan dengan terengah-engah maka hal tersebut menandakan bahwa latihan sudah melebihi intensitas yang

dianjurkan. Waktu pelaksanaan latihan yang dianjurkan adalah 30-60 menit. Tipe latihan yang dapat dilakukan adalah latihan aerobik, latihan kekuatan, serta latihan keseimbangan dan kelenturan.

Lansia yang secara rutin melakukan latihan peregangan statis maupun Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) mampu meningkatkan fleksibilitas bahu dan panggul lansia tanpa perbedaan hasil yang signifikan antara kedua jenis latihan peregangan tersebut. Perbaikan dan peningkatan pada fleksibilitas persendian melalui aktivitas peregangan statis berimplikasi terhadap aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, dan sebagainya serta mencegah hilangnya kapabilitas otot seiring bertambahnya usia (sarcopenia) (BKKBN, 2022).

Selain itu manfaat mempertahankan kelenturan tubuh antara lain Mempertahankan kelenturan tubuh bagi lansia memiliki banyak manfaat, di antaranya: meningkatkan performa fisik, melancarkan sirkulasi darah, mendukung postur tubuh, mengurangi ketegangan otot, meningkatkan koordinasi, menjaga keseimbangan tubuh, membantu mencegah risiko jatuh serta memperbaiki postur tubuh (BKKBN, 2022). Seiring bertambahnya usia, massa otot secara alami akan menurun dan kepadatan tulang pun berkurang, yang menyebabkan berkurangnya fleksibilitas. Namun, dengan melakukan peregangan secara rutin dan tetap aktif, kita dapat mengurangi penurunan alami ini dan meningkatkan fleksibilitas, mobilitas, dan gerakan kita secara keseluruhan.

BAB 3

KESEHATAN REMAJA DAN KEBUGARAN

A. Kesehatan Remaja dan Kebugaran

1. Kesehatan Remaja

Kesehatan remaja dapat didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang optimal, serta bukan sekadar ketiadaan penyakit atau kelemahan Sawyer (2009). Masa remaja merupakan periode transisi yang unik antara masa kanak-kanak dan dewasa, di mana individu mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Menurut penelitian oleh Aujoulat et al. (2018), promosi kesehatan remaja mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas remaja dalam mengelola tantangan kesehatan yang kompleks, termasuk kondisi kronis yang mungkin mereka hadapi.

Sawyer et al. (2007) menambahkan bahwa remaja dengan kondisi kesehatan kronis menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga kualitas hidup mereka, sehingga intervensi kesehatan yang berfokus pada promosi kesejahteraan menyeluruh sangat penting. Dalam konteks ini, kesehatan remaja tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan memuaskan.

2. Kebugaran Fisik dan Mental

Kebugaran fisik merujuk pada kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisiensi dan tanpa kelelahan yang berlebihan. Menurut Cattuzzo et al. (2016), kebugaran fisik pada remaja mencakup komponen seperti daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot, kelenturan, dan keseimbangan. Kebugaran ini erat kaitannya dengan kompetensi motorik, yang penting untuk mendukung kesehatan fisik sepanjang hayat.

Di sisi lain, kebugaran mental mengacu pada kondisi psikologis yang stabil, termasuk kemampuan untuk menghadapi stres, menjaga hubungan interpersonal yang sehat, dan mengembangkan potensi diri. Biddle & Asare (2011) menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara langsung memengaruhi kesehatan mental remaja, seperti mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Studi oleh Hosseinkhani et al. (2020) juga menegaskan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan penilaian kesehatan diri pada remaja melalui pengurangan stres akademik dan peningkatan prestasi akademik.

Herting & Chu (2017) menyoroti bahwa olahraga dan aktivitas fisik tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh tetapi juga mendukung perkembangan otak remaja. Hal ini penting untuk meningkatkan fungsi kognitif, seperti konsentrasi dan daya ingat, yang menjadi fondasi untuk keberhasilan di masa depan.

Dengan demikian, kesehatan remaja dan kebugaran mencakup aspek fisik dan mental yang saling terkait. Memahami kedua konsep ini secara mendalam adalah langkah awal untuk merancang intervensi yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup remaja.

3. Hubungan antara Kesehatan Remaja dan Kebugaran dalam Siklus Kehidupan

Kesehatan remaja dan kebugaran memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam siklus kehidupan. Masa remaja merupakan periode kritis untuk membangun fondasi kesehatan yang kuat, yang akan memengaruhi kualitas hidup di masa dewasa dan usia lanjut. Menurut Bay et al. (2017), remaja yang terlibat dalam perilaku sehat, seperti aktivitas fisik yang teratur dan pola makan seimbang, cenderung mempertahankan gaya hidup sehat sepanjang hidup mereka.

Studi oleh Biddle & Asare (2011) menunjukkan bahwa kebugaran fisik yang optimal pada remaja tidak hanya mendukung kesehatan saat ini tetapi juga berkontribusi pada pencegahan penyakit kronis, seperti obesitas dan penyakit kardiovaskular, di kemudian hari. Selain itu, kebugaran mental selama masa remaja, seperti kemampuan mengelola stres dan membangun hubungan sosial yang positif, memberikan perlindungan terhadap gangguan kesehatan mental di masa dewasa.

Hedman et al. (2017) menyoroti bahwa kesehatan remaja juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, seperti dukungan keluarga dan akses ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, promosi kesehatan pada remaja harus melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial.

Dalam siklus kehidupan, intervensi kesehatan dan kebugaran yang diterapkan pada masa remaja dapat menghasilkan efek domino yang positif. Salahshuri et al. (2014) menegaskan bahwa remaja yang memiliki kebiasaan hidup sehat lebih mungkin untuk menjadi dewasa yang produktif dan berkontribusi pada

masyarakat. Dengan demikian, investasi dalam kesehatan dan kebugaran remaja adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat dan tangguh di masa depan.

B. Tujuan Kesehatan Remaja dan Kebugaran

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Remaja

Kesehatan remaja dan kebugaran memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup remaja. Dalam konteks ini, kualitas hidup merujuk pada kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional yang memungkinkan remaja menjalani kehidupan secara optimal. Menurut penelitian oleh Aujoulat et al. (2018), intervensi promosi kesehatan yang tidak terfokus pada penyakit tertentu, tetapi pada kesejahteraan holistik, telah terbukti membantu remaja dengan kondisi kronis dalam meningkatkan kualitas hidup.

Biddle & Asare (2011) menekankan pentingnya aktivitas fisik dalam mengelola kesehatan mental dan emosional pada remaja. Aktivitas fisik tidak hanya berdampak positif pada kesehatan fisik, seperti peningkatan kekuatan otot dan kardiovaskular, tetapi juga membantu dalam mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan dan kebugaran adalah elemen kunci dalam mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik.

Selain itu Bay et al. (2017) mengidentifikasi bahwa pendidikan kesehatan melalui pengembangan literasi ilmiah di sekolah dapat memberdayakan remaja untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan remaja. Dengan memahami prinsip-prinsip kesehatan, remaja dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait gaya hidup sehat.

Hedman et al. (2017) menyoroti bahwa remaja perempuan dengan kondisi seperti asma cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, intervensi yang bertujuan meningkatkan kebugaran fisik dan mendukung kesehatan mental sangat penting untuk memastikan bahwa remaja mampu mengatasi tantangan yang dihadapi.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas hidup remaja melalui kesehatan dan kebugaran adalah tujuan strategis yang melibatkan pendekatan multidimensional. Kesehatan fisik yang optimal, dukungan kesehatan mental, literasi kesehatan, dan kemampuan mengelola tantangan merupakan komponen yang saling terkait untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam siklus kehidupan remaja dan selanjutnya.

2. Mempersiapkan Kesehatan Optimal di Masa Dewasa dan Lansia

Salah satu tujuan utama kesehatan remaja dan kebugaran adalah mempersiapkan individu untuk menjalani kehidupan yang sehat di masa dewasa dan lansia. Remaja merupakan fase kritis dalam siklus kehidupan, di mana berbagai kebiasaan sehat yang dibangun akan berkontribusi pada kesehatan jangka panjang. Sebagaimana dinyatakan oleh Herting & Chu (2017), aktivitas fisik pada masa remaja dapat berdampak langsung pada perkembangan otak, termasuk fungsi kognitif, yang kemudian mendukung kualitas hidup di usia lanjut.

Cattuzzo et al. (2016) mengungkapkan bahwa kompetensi motorik yang baik pada masa remaja tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga

memberikan dasar untuk partisipasi aktif dalam aktivitas fisik di kemudian hari. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa pola hidup aktif dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan osteoporosis pada usia dewasa dan lanjut usia.

Selain itu, menurut Costin et al. (2013), aktivitas fisik yang dilakukan selama masa remaja juga berperan dalam mengatur respons tubuh terhadap stres mental. Ini menunjukkan bahwa remaja yang terbiasa berolahraga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola stres, yang merupakan faktor risiko utama untuk berbagai penyakit kronis di usia dewasa.

Dari perspektif kesehatan mental, Hosseinkhani et al. (2020) menemukan bahwa aktivitas fisik tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup pada remaja. Efek positif ini terus berlanjut hingga masa dewasa, membantu individu menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan produktif.

Dengan demikian, investasi pada kesehatan remaja dan kebugaran adalah langkah strategis untuk memastikan generasi muda memiliki fondasi yang kuat dalam mencapai kesehatan optimal di masa depan. Kebiasaan sehat yang dimulai sejak remaja akan memberikan dampak positif yang berlanjut hingga akhir hayat, menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

3. Membentuk Kebiasaan Hidup Sehat yang Berkelanjutan

Kesehatan remaja dan kebugaran juga bertujuan untuk membentuk kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan sepanjang hidup. Masa remaja adalah

periode penting di mana individu mulai mengembangkan pola perilaku yang sering kali bertahan hingga dewasa. Kebiasaan seperti makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup merupakan elemen mendasar dari gaya hidup sehat.

Menurut Salahshuri et al. (2014), pendidikan kesehatan berbasis model kepercayaan kesehatan dapat membantu remaja memahami pentingnya gaya hidup sehat dan bagaimana kebiasaan tersebut memengaruhi kesehatan jangka panjang. Misalnya, dengan meningkatkan kesadaran tentang manfaat aktivitas fisik, remaja dapat termotivasi untuk menjaga rutinitas olahraga yang konsisten.

Sawyer et al. (2007) mencatat bahwa remaja dengan kondisi kesehatan kronis yang terpapar program promosi kesehatan yang tepat lebih cenderung mempertahankan perilaku hidup sehat di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pada masa remaja dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan sepanjang siklus kehidupan.

Swaminathan et al. (2020) menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam membangun kebiasaan sehat, termasuk keterlibatan keluarga dan komunitas. Dukungan dari lingkungan sosial dapat membantu remaja dalam mengatasi hambatan untuk menjalankan kebiasaan sehat, seperti kurangnya motivasi atau akses terhadap fasilitas kesehatan.

Selain itu, Langton & Berger, (2011) menunjukkan bahwa struktur keluarga dan dinamika sosial berperan penting dalam membentuk perilaku remaja terkait kesehatan. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan

keluarga yang mendukung cenderung lebih mampu membangun kebiasaan hidup sehat yang bertahan lama.

Dengan membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini, remaja tidak hanya meningkatkan kesehatan mereka sendiri tetapi juga menjadi agen perubahan yang dapat memengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, pendidikan dan dukungan yang tepat pada masa remaja adalah investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

C. Manfaat Kesehatan Remaja dan Kebugaran

1. Manfaat Fisik: Kekuatan, Daya Tahan, dan Pencegahan Penyakit

Manfaat kesehatan remaja dan kebugaran pada aspek fisik meliputi peningkatan kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan pencegahan berbagai penyakit. Menurut Indharty et al. (2023), aktivitas fisik yang teratur membantu meningkatkan kapasitas kardiovaskular, kelenturan, serta mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung koroner.

Sawyer (2009) menekankan pentingnya aktivitas fisik sebagai langkah preventif untuk meningkatkan fungsi sistem imun, sehingga remaja lebih mampu melawan infeksi. Selain itu, kebiasaan olahraga sejak remaja membantu memperbaiki postur tubuh, mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal, seperti nyeri punggung bawah, serta meningkatkan kepadatan tulang yang penting untuk mencegah osteoporosis di masa dewasa.

Tremblay et al. (2016) menyatakan bahwa aktivitas fisik juga berkontribusi pada peningkatan energi dan konsentrasi, yang secara tidak langsung mendukung performa akademik remaja. Dengan demikian, investasi

dalam kebugaran fisik sejak remaja memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan.

2. Manfaat Psikologis: Kesehatan Mental dan Kepercayaan Diri

Manfaat kesehatan remaja dan kebugaran juga sangat terasa pada aspek psikologis, terutama dalam mendukung kesehatan mental dan meningkatkan kepercayaan diri. Menurut Lubans et al. (2016), olahraga dapat merangsang pelepasan endorfin dan serotonin, yang berperan dalam memperbaiki suasana hati dan mengurangi gejala depresi dan kecemasan.

Sawyer (2009) menggarisbawahi bahwa aktivitas fisik memberikan struktur dan rutinitas yang dapat membantu remaja mengelola stres. Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas kelompok juga memberikan rasa pencapaian yang meningkatkan harga diri. Sebagai contoh, keberhasilan mencapai target dalam program latihan fisik dapat memperkuat kepercayaan diri remaja, yang penting dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

Eime et al. (2013) menyoroti bahwa remaja yang aktif secara fisik cenderung memiliki citra tubuh yang positif, yang berkontribusi pada kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, kebugaran tidak hanya memperkuat kesehatan fisik tetapi juga menjadi fondasi bagi kesehatan mental yang kokoh.

3. Manfaat Sosial: Interaksi dan Kerja Sama

Kesehatan remaja dan kebugaran juga berdampak positif pada aspek sosial, terutama melalui peningkatan interaksi dan kerja sama. Aktivitas olahraga, terutama yang bersifat tim, memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab.

Holt et al. (2017) menyebutkan bahwa olahraga tim memberikan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk belajar bekerja sama dan menghargai perbedaan. Hal ini membantu mereka membangun hubungan sosial yang positif, yang penting untuk menghindari isolasi sosial atau perilaku berisiko seperti kenakalan remaja.

Sawyer (2009) menambahkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas fisik juga mendorong pembentukan jaringan sosial yang sehat, yang dapat memberikan dukungan emosional dan meningkatkan rasa kebersamaan. Partisipasi aktif dalam komunitas olahraga menciptakan peluang bagi remaja untuk mempelajari nilai-nilai kerja sama, empati, dan saling menghargai, yang esensial dalam membangun karakter dan hubungan sosial yang harmonis.

Secara keseluruhan, manfaat fisik, psikologis, dan sosial dari kesehatan remaja dan kebugaran saling terkait dalam membentuk individu yang sehat dan produktif. Investasi dalam kebugaran remaja memberikan dampak positif yang berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan.

D. Bentuk Kesehatan Remaja dan Kebugaran

1. Aktivitas Fisik dan Olahraga

Aktivitas fisik dan olahraga merupakan salah satu bentuk utama dalam menjaga kesehatan remaja dan kebugaran. Menurut Sawyer (2009), olahraga yang teratur membantu meningkatkan kapasitas kardiovaskular, kekuatan otot, dan kelenturan tubuh. Aktivitas fisik juga berperan penting dalam menjaga berat badan ideal dan mengurangi risiko obesitas, yang dapat menjadi faktor predisposisi berbagai penyakit kronis di masa depan.

Tremblay et al. (2016) menyarankan bahwa remaja sebaiknya melakukan aktivitas fisik intensitas sedang

hingga tinggi selama minimal 60 menit per hari. Aktivitas ini dapat berupa olahraga tim seperti sepak bola atau bola basket, latihan kekuatan seperti push-up dan angkat beban ringan, atau aktivitas rekreasi seperti bersepeda dan berenang. Partisipasi dalam olahraga juga membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial, seperti kerja sama tim dan kepemimpinan.

Selain manfaat fisik, olahraga secara langsung berdampak positif pada kesehatan mental remaja. Seperti yang dijelaskan oleh Lubans et al. (2016), aktivitas fisik merangsang pelepasan endorfin, yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi gejala kecemasan serta depresi.

2. Pola Makan Sehat

Pola makan sehat adalah fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal pada masa remaja. Menurut Sawyer (2009), remaja membutuhkan asupan nutrisi yang seimbang untuk mendukung aktivitas fisik, perkembangan otak, dan fungsi tubuh yang optimal. Nutrisi penting yang harus diperhatikan meliputi protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, dan mineral.

Langton & Berger (2011) menekankan pentingnya konsumsi sayur, buah, dan produk gandum utuh sebagai bagian dari pola makan sehat. Mengurangi asupan gula, makanan olahan, dan lemak trans juga merupakan langkah strategis untuk mencegah obesitas dan penyakit metabolik.

Selain itu, pendidikan tentang kebiasaan makan sehat dapat meningkatkan literasi gizi pada remaja. Salahshuri et al. (2014) menyatakan bahwa pengetahuan gizi yang baik memungkinkan remaja membuat

keputusan yang tepat dalam memilih makanan sehari-hari. Misalnya, menggantikan camilan tidak sehat dengan kacang-kacangan atau yogurt rendah lemak dapat memberikan energi yang berkelanjutan tanpa meningkatkan risiko obesitas.

3. Kebersihan dan Kesehatan Pribadi

Kebersihan dan kesehatan pribadi adalah komponen penting dari kesehatan remaja dan kebugaran. S. Sawyer, (2009) mencatat bahwa menjaga kebersihan tubuh, seperti mandi secara teratur, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan gigi, dapat mencegah berbagai infeksi dan penyakit. Remaja juga harus diajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan pakaian dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit menular.

Hedman et al. (2017) menyoroti pentingnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kebersihan pribadi. Ini termasuk pemahaman tentang siklus menstruasi, penggunaan produk kebersihan yang tepat, dan menjaga kebersihan alat reproduksi. Dengan informasi yang memadai, remaja dapat lebih siap untuk menjaga kesehatan pribadi mereka secara keseluruhan.

4. Istirahat dan Manajemen Stres

Istirahat yang cukup dan manajemen stres adalah elemen penting lainnya dalam kesehatan remaja. Menurut Hosseinkhani et al. (2020), remaja membutuhkan rata-rata 8–10 jam tidur setiap malam untuk mendukung fungsi kognitif dan fisik. Kurang tidur dapat berdampak negatif pada performa akademik, suasana hati, dan sistem kekebalan tubuh.

Manajemen stres juga menjadi tantangan yang signifikan bagi remaja. Swaminathan et al. (2020)

mencatat bahwa teknik seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan dapat membantu remaja mengelola stres dengan lebih baik. Aktivitas fisik juga berfungsi sebagai alat manajemen stres yang efektif dengan merangsang pelepasan hormon serotonin.

Dukungan dari keluarga dan teman sebaya juga memainkan peran penting dalam membantu remaja menghadapi stres. Salahshuri et al. (2014) mencatat bahwa lingkungan yang mendukung memungkinkan remaja merasa lebih percaya diri dan mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kombinasi antara istirahat yang cukup dan strategi manajemen stres yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental remaja.

E. Prinsip-prinsip Kesehatan Remaja dan Kebugaran

Kesehatan remaja dan kebugaran memainkan peran penting dalam membentuk fondasi kehidupan yang sehat di masa dewasa. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari kesehatan remaja dan kebugaran memberikan pedoman untuk mencapainya, yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan spesifik individu. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk mendukung perubahan gaya hidup sehat di kalangan remaja, baik dalam konteks fisik, mental, maupun sosial. Beberapa prinsip utama dalam kesehatan remaja dan kebugaran yang harus diperhatikan meliputi keberlanjutan, keseimbangan, individualitas, dan progresivitas.

1. Prinsip Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah prinsip yang mengedepankan pentingnya menjaga kebiasaan sehat secara jangka panjang, bukan hanya sebagai upaya sementara. Hal ini berkaitan dengan penerapan pola hidup sehat yang dapat dipertahankan seiring waktu. Remaja yang mengadopsi

kebiasaan gaya hidup sehat yang berkelanjutan cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih mampu mengatasi tantangan kesehatan di masa depan (Aujoulat et al., 2018). Prinsip ini mencakup perlunya pendidikan yang berkesinambungan tentang kebiasaan sehat dan kebugaran agar dapat mendorong perilaku yang bertahan lama (Bay et al., 2017).

2. Prinsip Keseimbangan (Fisikal, Mental, dan Sosial)

Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan remaja, seperti fisik, mental, dan sosial. Kesehatan fisik, seperti melalui olahraga, penting untuk meningkatkan kebugaran dan mengurangi risiko penyakit. Kesehatan mental juga tak kalah penting, karena remaja yang sehat mental lebih mampu mengatasi tekanan akademis dan sosial (Biddle & Asare, 2011). Selain itu, keseimbangan sosial membantu remaja mengembangkan hubungan yang positif dengan keluarga, teman, dan komunitas mereka (Langton & Berger, 2011). Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada perkembangan kesejahteraan holistik remaja.

3. Prinsip Individualitas dan Kebutuhan Spesifik

Setiap remaja memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda dalam hal kesehatan dan kebugaran. Prinsip ini mengakui bahwa tidak ada pendekatan yang seragam dalam mencapai kesehatan optimal. Setiap individu memiliki kekuatan, kelemahan, dan kondisi medis yang unik yang harus diperhitungkan dalam merancang intervensi kesehatan. Misalnya, remaja dengan kondisi medis tertentu, seperti asma, mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan remaja tanpa kondisi medis (Hedman et al., 2017). Oleh karena

itu, penting untuk merancang program kesehatan dan kebugaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

4. Prinsip Progresivitas

Prinsip progresivitas mengacu pada perlunya peningkatan bertahap dalam aktivitas fisik dan kebugaran. Peningkatan yang progresif memungkinkan remaja untuk mengembangkan kekuatan, daya tahan, dan kemampuan fisik secara bertahap dan terukur. Hal ini juga berperan dalam pencegahan cedera dan stres fisik yang berlebihan. Program kebugaran yang dirancang dengan prinsip progresivitas dapat membantu remaja mencapai tujuan kebugaran yang lebih besar dan lebih ambisius dalam jangka panjang (Cattuzzo et al., 2016). Progresivitas dalam olahraga dan kebugaran juga mendukung perkembangan mental yang lebih baik, karena remaja merasa termotivasi dan berhasil saat melihat kemajuan dalam usaha mereka (Herting & Chu, 2017).

F. Ruang Lingkup Kesehatan Remaja dan Kebugaran

Kesehatan remaja merupakan aspek yang sangat luas dan mencakup berbagai dimensi penting dalam kehidupan. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental, dan sosial, kesehatan reproduksi juga merupakan bagian integral dari kesehatan remaja. Setiap dimensi ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, membentuk dasar kebugaran secara keseluruhan. Ruang lingkup kesehatan remaja dan kebugaran, mencakup empat aspek utama, yaitu kesehatan fisik, mental, sosial, dan reproduksi remaja.

1. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik pada remaja mencakup kondisi tubuh yang bebas dari penyakit atau gangguan dan kemampuan tubuh untuk berfungsi dengan baik dalam

aktivitas sehari-hari. Kesehatan fisik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola makan, aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan kebiasaan hidup sehat lainnya (Costin et al., 2013). Olahraga teratur dan pola makan yang seimbang sangat penting untuk meningkatkan kekuatan tubuh, daya tahan, dan kesehatan jantung pada remaja (Biddle & Asare, 2011). Selain itu, kebiasaan fisik yang sehat pada masa remaja akan membentuk fondasi yang kuat bagi kesehatan tubuh di masa dewasa (Cattuzzo et al., 2016).

Penting juga untuk menjaga keseimbangan dalam aktivitas fisik yang dilakukan oleh remaja. Aktivitas fisik yang terlalu berlebihan atau tidak seimbang dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan lainnya (Indharty et al., 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang bijak dalam menjaga kebugaran fisik akan berkontribusi pada kesehatan yang optimal di masa depan.

2. Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah dimensi yang tidak kalah penting dalam kesehatan remaja. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan emosi dan mental seseorang. Selama periode ini, remaja cenderung mengalami banyak perubahan, baik fisik maupun psikologis, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Masalah seperti stres akademik, kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku sering kali muncul pada remaja, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka (Hosseinkhani et al., 2020).

Penting untuk memberikan dukungan emosional yang memadai kepada remaja melalui pendidikan kesehatan mental yang memadai dan sumber daya yang dapat membantu mereka mengatasi tekanan. Selain itu,

keterlibatan dalam aktivitas fisik, seperti olahraga, dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental remaja dengan mengurangi kecemasan dan meningkatkan mood secara keseluruhan (Biddle & Asare, 2011). Melalui pendekatan yang holistik dan dukungan dari keluarga serta komunitas, kesehatan mental remaja dapat ditingkatkan.

3. Kesehatan Sosial

Kesehatan sosial mencakup kemampuan remaja untuk berinteraksi dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Hubungan sosial yang baik dengan keluarga, teman, dan komunitas sangat penting untuk perkembangan remaja. Interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan rasa aman serta dukungan emosional yang penting bagi kesehatan mental (S. M. Sawyer et al., 2007). Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial atau isolasi sosial dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya pada remaja (Langton & Berger, 2011).

Pendidikan tentang keterampilan sosial dan komunikasi yang efektif dapat membantu remaja mengembangkan hubungan yang sehat dan memperkuat ikatan sosial mereka. Selain itu, kebiasaan sosial yang sehat, seperti partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler atau komunitas, dapat memperkaya kehidupan sosial remaja dan mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

4. Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi remaja adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan remaja. Pada masa remaja, perubahan hormon dan

perkembangan fisik mempengaruhi sistem reproduksi, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan tertentu, seperti gangguan menstruasi, dismenore, atau infeksi saluran reproduksi (Sawyer, 2009). Selain itu, pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan gangguan kesehatan reproduksi lainnya di kalangan remaja.

Pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang tepat sangat penting untuk membantu remaja memahami perubahan yang terjadi dalam tubuh mereka dan cara menjaga kesehatan reproduksi dengan baik (Aujoulat et al., 2018). Pendekatan yang holistik dalam pendidikan kesehatan reproduksi harus mencakup informasi yang tepat tentang penggunaan kontrasepsi, pencegahan penyakit menular seksual, serta perawatan tubuh secara umum.

G. Intervensi Kesehatan Remaja dan Kebugaran

Kesehatan remaja dan kebugaran memerlukan perhatian yang holistik dari berbagai sektor. Intervensi kesehatan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan remaja dan mencegah masalah kesehatan jangka panjang. Pendekatan intervensi yang dapat diterapkan untuk mendukung kesehatan remaja, antarlain: intervensi berbasis sekolah, peran keluarga dan komunitas, kebijakan pemerintah dan program kesehatan nasional, serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kesehatan remaja.

1. Intervensi Berbasis Sekolah

Sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan remaja. Sebagai tempat pendidikan dan interaksi sosial utama, sekolah dapat

menjadi wadah yang efektif untuk intervensi kesehatan yang mempromosikan kebugaran fisik dan mental remaja. Salah satu bentuk intervensi berbasis sekolah adalah pendidikan kesehatan yang terintegrasi dalam kurikulum, yang mencakup topik-topik seperti gizi, aktivitas fisik, kesehatan mental, dan perilaku hidup sehat (Bay et al., 2017).

Program-program yang berfokus pada peningkatan aktivitas fisik di sekolah juga sangat bermanfaat. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik remaja, serta berperan dalam mengurangi kecemasan dan stres (Herting & Chu, 2017). Selain itu, program seperti olahraga terstruktur, klub kebugaran, dan kelas keterampilan hidup dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Cattuzzo et al., 2016).

Di sekolah, pendekatan berbasis keterlibatan juga efektif, seperti program yang melibatkan remaja dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan kebugaran atau kegiatan pencegahan gangguan mental. Melalui pendekatan ini, remaja dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesehatan di kalangan teman sebaya mereka (Swaminathan et al., 2020).

2. Peran Keluarga dan Komunitas

Keluarga dan komunitas memiliki peran yang tak terpisahkan dalam mendukung kesehatan dan kebugaran remaja. Keluarga adalah sumber utama dukungan emosional dan fisik yang membantu remaja mengelola stres dan tantangan hidup. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi keluarga tentang pentingnya gaya hidup sehat, seperti menyediakan makanan bergizi, mendukung

aktivitas fisik, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan mental remaja (Langton & Berger, 2011).

Selain itu, komunitas dapat berfungsi sebagai tempat untuk memfasilitasi intervensi kesehatan yang lebih luas. Kegiatan komunitas yang mendukung kebugaran fisik dan mental, seperti pusat kebugaran remaja, program olahraga, atau dukungan sosial bagi remaja yang mengalami gangguan mental, sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan remaja secara keseluruhan (Dahli et al., 2017). Komunitas yang peduli juga dapat menyediakan ruang untuk remaja berbagi pengalaman dan memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan mereka.

3. Kebijakan Pemerintah dan Program Kesehatan Nasional

Kebijakan pemerintah dan program kesehatan nasional memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan remaja. Pemerintah dapat mengimplementasikan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan remaja melalui pendidikan, pencegahan penyakit, dan pengembangan layanan kesehatan yang ramah remaja. Salah satu contoh program kesehatan nasional adalah program vaksinasi remaja, yang bertujuan untuk melindungi remaja dari penyakit menular seperti HPV, yang dapat menyebabkan kanker serviks di masa depan (Sawyer, 2009).

Selain itu, kebijakan yang mendukung kesehatan mental dan pencegahan gangguan kesehatan mental pada remaja juga sangat penting. Program kesehatan mental berbasis sekolah yang melibatkan tenaga

profesional, seperti konselor atau psikolog, dapat memberikan dukungan psikososial kepada remaja (Hosseinkhani et al., 2020). Pemerintah juga dapat memfasilitasi akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk pendidikan mengenai kontrasepsi, pencegahan penyakit menular seksual, dan kesehatan reproduksi secara umum.

4. Penggunaan Teknologi dalam Kesehatan Remaja

Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung kesehatan remaja. Penggunaan aplikasi kesehatan, platform daring, dan media sosial dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi remaja untuk memperoleh informasi kesehatan yang relevan dan terpercaya. Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau kesehatan fisik dan mental remaja, seperti aplikasi yang mengukur aktivitas fisik, pola tidur, dan bahkan memantau gejala gangguan mental (Yoon et al., 2017).

Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk mengedukasi remaja melalui materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Platform daring dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kebiasaan hidup sehat yang lebih menarik bagi remaja (Swaminathan et al., 2020). Media sosial juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan kampanye kesadaran mengenai pentingnya gaya hidup sehat dan menghubungkan remaja dengan sumber daya kesehatan yang dapat membantu mereka menjaga kebugaran tubuh dan mental.

Namun, penting juga untuk memantau penggunaan teknologi ini dengan hati-hati. Kelebihan penggunaan teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi

kesehatan mental remaja, meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang dalam penggunaan teknologi untuk kesehatan remaja sangat diperlukan untuk memastikan dampak positif yang maksimal.

H. Dampak Kesehatan Remaja dan Kebugaran saat Lansia

Kesehatan remaja dan kebugaran tidak hanya penting untuk kehidupan saat ini, tetapi juga memainkan peran krusial dalam mempengaruhi kualitas hidup di masa depan, terutama saat memasuki usia lanjut. Gaya hidup sehat yang dibangun sejak usia remaja dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial di usia tua.

1. Hubungan antara Gaya Hidup Remaja dan Kesehatan Lansia

Gaya hidup sehat yang diterapkan selama masa remaja, seperti pola makan bergizi, aktivitas fisik yang teratur, serta menjaga keseimbangan mental dan sosial, dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan di usia lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan sehat yang dimulai sejak usia remaja dapat mengurangi risiko penyakit degeneratif yang biasa ditemukan pada lansia, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan gangguan kognitif (Biddle & Asare, 2011; S. Sawyer, 2009). Aktivitas fisik yang teratur, misalnya, meningkatkan daya tahan tubuh dan kebugaran jantung, yang akan berkontribusi pada kesehatan sistem kardiovaskular di usia tua (Yoon et al., 2017).

Selain itu, kebiasaan menjaga kesehatan mental yang dibangun sejak remaja, seperti mengelola stres dan menjaga keseimbangan emosional, dapat mencegah gangguan mental pada usia lanjut, termasuk depresi dan

kecemasan (Costin et al., 2013). Remaja yang terpapar pada pendidikan kesehatan yang mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik cenderung memiliki pandangan hidup yang lebih positif di masa depan, yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka saat memasuki usia lanjut (Dahli et al., 2017).

Sebaliknya, gaya hidup yang tidak sehat selama masa remaja, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, pola makan buruk, dan kurangnya aktivitas fisik, dapat meningkatkan risiko berkembangnya berbagai penyakit serius pada lansia, termasuk obesitas, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya (Swaminathan et al., 2020). Oleh karena itu, pendidikan dan intervensi kesehatan sejak dini sangat penting untuk membentuk pola hidup sehat yang dapat memberikan dampak positif di masa depan.

2. Pencegahan Penyakit Degeneratif

Penyakit degeneratif adalah kondisi yang berkembang seiring dengan bertambahnya usia, namun banyak di antaranya yang dapat dicegah dengan menjaga gaya hidup sehat sejak usia muda. Beberapa penyakit degeneratif, seperti osteoarthritis, osteoporosis, hipertensi, diabetes tipe 2, dan demensia, dapat dikendalikan atau bahkan dihindari dengan intervensi yang dimulai dari masa remaja (Cattuzzo et al., 2016).

Salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyakit degeneratif adalah dengan memastikan bahwa remaja tetap aktif secara fisik. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menjaga kepadatan tulang dan massa otot, meningkatkan metabolisme, serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular (Herting & Chu, 2017). Olahraga yang dilakukan sejak remaja tidak hanya membantu tubuh

tetap bugar, tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan mengurangi stres dan kecemasan, yang merupakan faktor risiko untuk penyakit degeneratif (Biddle & Asare, 2011).

Selain itu, pola makan yang bergizi, yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral, serta rendah lemak jenuh dan gula, sangat penting dalam mencegah penyakit degeneratif. Edukasi tentang pentingnya pola makan sehat dapat dimulai sejak dini, sehingga remaja akan memiliki kebiasaan makan yang baik yang dapat bertahan hingga mereka lanjut usia (Sawyer et al., 2007). Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan juga merupakan langkah penting dalam mencegah perkembangan penyakit degeneratif di masa tua.

3. Kontribusi Terhadap Umur Panjang dan Kualitas Hidup Lansia

Kesehatan remaja yang optimal berkontribusi terhadap umur panjang dan kualitas hidup lansia. Remaja yang mempraktikkan kebiasaan sehat cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mencapai usia lanjut dengan kesehatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang aktif secara fisik dan memiliki pola makan sehat dapat hidup lebih lama dan lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tidak menjalani gaya hidup sehat (Aujoulat et al., 2018).

Kesehatan mental yang terjaga sejak remaja juga memberikan kontribusi penting terhadap umur panjang. Remaja yang dilatih untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan emosional cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, yang dapat melindungi

mereka dari penyakit yang terkait dengan penuaan (Hosseinkhani et al., 2020). Remaja yang mengembangkan keterampilan sosial yang baik dan memiliki dukungan keluarga serta komunitas yang kuat juga lebih mungkin untuk menikmati kualitas hidup yang lebih tinggi di usia tua (Langton & Berger, 2011).

Selain itu, dukungan sosial yang kuat dan hubungan sosial yang positif selama masa remaja dapat berlanjut hingga usia lanjut, meningkatkan kualitas hidup lansia. Remaja yang terbiasa dengan interaksi sosial yang sehat dan konstruktif cenderung lebih mampu mengatasi tantangan hidup, baik itu masalah fisik maupun mental, di usia lanjut (Sawyer et al., 2007).

BAB 4

GIZI PADA MASA LANJUT USIA (LANSIA)

A. Pengertian Lanjut Usia (Lansia)

Lansia (lanjut usia) adalah kelompok umur 60 tahun atau lebih yang telah memasuki tahapan akhir fase kehidupannya (Gunawan, 2011). Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan (Nugroho, 2008).

Menua (aging) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang ada (Darmojo, 2004). Dengan begitu manusia secara progresif akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi dan akan menumpuk makin banyak distorsi metabolik dan struktural yang disebut penyakit degenerative (Darmojo, 2011). Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2003, lansia dibagi atas:

1. Lansia dini (pralansia): usia 45-59 tahun
2. Lansia: usia 60 tahun atau lebih
3. Lansia risiko tinggi: usia 70 tahun atau lebih

B. Perubahan pada Lansia

1. Perubahan Fisiologis

Perubahan fisiologi yang terjadi pada lansia meliputi (Adriani &wiratmadi, 2012):

- a. Perubahan kecepatan metabolik basal (BMR) sekitar 2% dekade setelah usia 30 tahun dan penurunan aktivitas fisik sehingga memengaruhi kebutuhan kalori, yaitu menurun dan berpotensi untuk obesitas.
- b. Gangguan kemampuan motorik sehingga berdampak kesulitan untuk menyiapkan makanan, penurunan pengeluaran energi sehingga berpotensi dalam peningkatan berat badan.
- c. Perubahan pada saluran pencernaan:
 - 1) Rongga mulut, bagian dalam rongga mulut yang lazim berpengaruh adalah gusi, gigi dan lidah. Sekresi ludah berkurang sampai +75% sehingga mengakibatkan pengeringan rongga mulut dan kemungkinan menurunkan cita rasa. Kehilangan indra pengecap, penurunan ketajaman pengecap, kerusakan indra penciuman berdampak kurang tertarik pada makanan. Penyakit periodontal yang 80% terjadi pada orang tua dan kehilangan gigi sehingga menyebabkan kesulitan makan.
 - 2) Jumlah jaringan ikat meningkat sehingga fungsi pemompaan jantung berkurang.
 - 3) Pembekuan darah besar terutama aorta melebar dan menjadi fibrosis, pengerasan ini selain mengurangi aliran darah dan meningkatkan kerja bilik kiri jantung, juga mengakibatkan ketidakefisien

reseptor sehingga kemampuan tubuh untuk mengatur tekanan darah berkurang.

- d. Perubahan pada sistem hematologi, adanya penurunan jumlah limfosit yang dimulai pada usia 40 tahun, penurunan tersebut diyakini akibat hilangnya sel T limfosit. Jumlah limfosit kurang dapat mengakibatkan tubuh rentan terhadap infeksi dan juga lebih berisiko terhadap kanker, serta kerusakan berbagai organ.
- e. Seiring menggunakan obat-obatan sehingga dapat mengganggu nafsu makan dan menyebabkan penurunan penyerapan (penggunaan zat gizi atau peningkatan kebutuhan zat gizi).

2. Perubahan Mental dan Psikososial

Menurut Aspiani (2014) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perubahan mental pada lansia yaitu kesehatan, tingkat pendidikan, lingkungan, keturunan, dan perubahan fisik terutama panca indera. Selain perubahan mental, lansia juga mengalami perubahan psikososial seperti:

- a. Lansia cenderung merasakan sadar atau tidak sadar akan terjadinya kematian.
- b. Merasakan perubahan dalam cara hidup.
- c. Merasakan perubahan ekonomi akibat pemberhentian jabatan dan peningkatan gaya hidup.
- d. Merasakan pension. (kehilangan) banyak hal seperti finansial, pekerjaan, sahabat, dan status pekerjaan.
- e. Merasakan penyakit kronis dan ketidakmampuan.
- f. Merasakan kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial.

- g. Mengalami gangguan pancaindra.
- h. Lansia mulai mengalami perubahan dalam konsep diri, serta lansia akan merasakan rangkaian dari proses kehilangan.

3. Perubahan Biologis

Perubahan secara biologis ini dapat memengaruhi status gizi pada masa tua antara lain (Adriani & wiratmadi, 2012):

- a. Massa otot yang berkurang dan massa lemak yang bertambah, mengakibatkan jumlah cairan tubuh juga berkurang, sehingga kulit kelihatan mengkerut dan kurus, wajah berlipat serta muncul garis yang menetap oleh karena itu, pada masa usia lanjut seringkali terlihat kurus.
- b. Penurunan indera penglihatan akibat katarak pada usia lanjut sehingga dihubungkan dengan kekurangan vitamin a, vitamin c dan asam folat. Sedangkan gangguan pada indera pengecap yang dihubungkan dengan kadar Zn dapat menurunkan nafsu makan. Biasanya para usia lanjut yang menginjak usia 75 tahun, hanya memiliki pengecapan setengah dari pada saat mereka berusia 30 tahun.
- c. Dengan banyaknya gigi geligi yang sudah tanggal mengakibatkan gangguan fungsi mengunyah yang berdampak pada kurangnya asupan gizi pada usia lanjut.
- d. Penurunan mobilitas usus, menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti perut kembung, nyeri yang menyebabkan turunnya nafsu makan usia lanjut, sehingga menyebabkan sekresi kelenjar-kelenjar di

saluran pencernaan makanan menurun. Berkurangnya sekresi HCl lambung mengakibatkan gangguan penyerapan kalsium dan zat besi. Menurunnya sekresi enzim lipase mengakibatkan gangguan absorpsi lemak.

- e. Kemampuan motorik yang menurun, selain menyebabkan usia lanjut menjadi lamban, kurang aktif dan kesulitan untuk mengecap makanan, dapat mengganggu aktivitas atau kegiatan sehari-hari.
- f. Pada usia lanjut terjadi penurunan fungsi sel otak yang menyebabkan penurunan daya ingat jangka pendek, melambatnya proses informasi, kesulitan berbahasa, kesulitan mengenal benda-benda, kegagalan melakukan aktivitas bertujuan, dan gangguan dalam menyusun rencana, mengatur sesuatu, mengurutkan, daya abstraksi yang dapat melakukan aktivitas sehari-hari yang disebut demensia atau pikun.
- g. Akibat proses menua, kapasitas gagal ginjal untuk mengeluarkan air dalam jumlah besar juga berkurang. Akibatnya dapat terjadi pengenceran natrium sampai terjadi hiponatremia yang menimbulkan rasa lelah.
- h. Pada wanita terjadi penurunan sekresi hormon estrogen, yang menyebabkan mudahnya terjadi peningkatan kadar kolesterol darah, terganggunya absorpsi kalsium yang dapat mengakibatkan kepadatan tulang menurun, tulang mudah patah yang dikenal sebagai "*osteoporosis*"

C. Status Gizi Lansia

Status gizi adalah keadaan tubuh manusia sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Adapun kategori dari status gizi dibedakan menjadi tiga yaitu gizi lebih, gizi baik, dan gizi kurang. Baik buruknya status gizi manusia dipengaruhi oleh 2 hal pokok yaitu konsumsi makanan dan keadaan kesehatan tubuh atau infeksi. Dalam ilmu gizi, status gizi lebih dan status gizi kurang disebut sebagai malnutrisi, yakni keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif ataupun absolut satu atau lebih zat gizi (Mardalena, 2017).

Status gizi lansia adalah keadaan lansia yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik terhadap energi dan zat-zat gizi yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya dapat diukur. Perbandingan perhitungan rata-rata kebutuhan gizi dengan jumlah asupan zat gizi dapat memberikan indikasi ada tidaknya masalah gizi. (Fatmah, 2013). Terdapat empat bentuk malnutrisi, terdiri dari :

1. *Under nutrition* yaitu kekurangan konsumsi pangan relative atau absolut untuk periode tertentu,
2. *Specific deficiency* yaitu kekurangan zat gizi tertentu,
3. *Over nutrition* yaitu kelebihan konsumsi pangan dalam periode tertentu, dan
4. *Imbalance*, yaitu disporposi zat gizi misalnya masalah kolesterol terjadi karena ketidakseimbangan fraksi lemak tubu. Jadi jelaslah bahwa ternyataa malnurtrisi bukan hanya gizi kurang saja (Mardalena, 2017).

D. Penilaian Status Gizi Lansia

Penilaian status gizi lansia diukur dengan antropometri atau ukuran tubuh, yaitu tinggi badan (TB) dan berat badan (BB). Akan tetapi pengukuran tinggi badan lansia sangat sulit dilakukan mengingat adanya beberapa lansia mengalami masalah postur tubuh seperti adanya kifosis atau pembengkokan tulang punggung, sehingga lansia tidak dapat berdiri tegak. Oleh karena itu pengukuran tinggi lutut dapat dilakukan untuk memperkirakan tinggi badan (Fatmah, 2010).

Indeks masa tubuh (IMT) adalah berat badan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Indeks masa tubuh merupakan cara untuk menggambarkan berat badan dalam hubungannya dengan tinggi badan (Supriasa, 2001). IMT merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa yang berumur diatas 18 tahun khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. IMT tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil dan olahragawan (Marmi, 2013).

Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut:

$$IMT = \frac{Berat\ Badan\ (kg)}{(Tinggi\ Badan\ (m))^2}$$

Untuk mengetahui status gizi seseorang maka ada kategori ambang batas IMT yang digunakan, seperti yang terlihat pada Tabel 1 yang merupakan ambang IMT lansia.

Tabel 4.1 Kategori Ambang Batas IMT

Kategori		IMT
Kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat	<17,0
	Kekurangan berat badan tingkat ringan	17,0 – 18,4
Normal	Normal	18,5 – 25,0
Gemuk	Kelebihan berat badan tingkat ringan	25,1 – 27,0
	Kelebihan berat badan tingkat berat	> 27,0

Sumber : *Depkes (2018)*

E. Masalah Gizi Lansia

Menurut Asra & Sumiati (2007) pada lansia terdapat dua masalah gizi yaitu gizi lebih dan gizi kurang:

1. Gizi lebih

Prevalensi obesitas menunjukkan peningkatan sesuai dengan pertambahan usia. Pada umumnya berat badan laki-laki mencapai puncak pada usia 50-55 tahun. Pada wanita antara usia 55-60 tingkat metabolisme basal dan pengeluaran untuk aktivitas fisik menurun saat memasuki usia dewasa. Akan tetapi asupan kalori tidak diimbangi sehingga berat badan meningkat.

2. Gizi kurang

Penurunan asupan kalori biasanya sejalan dengan penurunan tingkat metabolisme susutnya masa tubuh serta menurunnya penggunaan energi untuk aktivitas fisik. Hampir 20% lansia mengkonsumsi 1000 kalori sehari kekurangan protein kalori umum ditemukan pada lansia.

Masalah gizi lanjut usia merupakan rangkaian proses masalah gizi sejak usia muda yang manifestasinya terjadi pada lanjut usia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masalah gizi pada lanjut usia sebagian besar merupakan masalah gizi lebih yang merupakan faktor risiko timbulnya penyakit degenerative seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, gout rematik, ginjal, perlemakan hati, dan lain-lain. Namun demikian masalah kurang gizi juga banyak terjadi pada lanjut usia seperti Kurang Energi Kronik (KEK), anemia dan kekurangan zat gizi mikro lain (Kemenkes RI, 2012).

Dampak apabila terjadinya masalah gizi pada lansia adalah sebagai berikut (Kemenkes RI, 2012):

1. Kegemukan atau obesitas

Keadaan ini biasanya disebabkan oleh pola konsumsi yang berlebihan, banyak mengandung lemak dan jumlah kalori yang melebihi kebutuhan. Proses metabolisme yang menurun pada lanjut usia, bila tidak diimbangi dengan peningkatan aktifitas fisik atau penurunan jumlah makanan, sehingga jumlah kalori yang berlebih akan diubah menjadi lemak yang dapat mengakibatkan kegemukan. Selain kegemukan secara keseluruhan, kegemukan pada bagian perut lebih berbahaya karena kelebihan lemak di perut dihubungkan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung koroner pada bagian lemak lain. Kegemukan atau obesitas akan meningkatkan risiko menderita penyakit jantung koroner 1-3 kali, penyakit hipertensi 1,5 kali, diabetes mellitus 2,9 kali dan penyakit empedu 1-6 kali.

2. Kurang Energi Kronik (KEK)

Kurang atau hilangnya nafsu makan yang berkepanjangan pada lanjut usia, dapat menyebabkan penurunan berat badan. Pada lanjut usia kulit dan jaringan ikat mulai keriput, sehingga makin kelihatan kurus. Disamping kekurangan zat gizi makro, sering juga disertai kekurangan zat gizi mikro. Beberapa penyebab KEK pada lanjut usia :

- a. Makan tidak enak karena berkurangnya fungsi alat perasa dan penciuman
 - b. Gigi-geligi yang tanggal, sehingga mengganggu proses mengunyah makanan
 - c. Faktor stress/depresi, kesepian, penyakit kronik, efek samping obat, merokok, dll.
3. Kurang Zat Gizi Mikro lain

Biasanya menyertai lanjut usia dengan KEK, namun kekurangan zat gizi mikro dapat juga terjadi pada lanjut usia dengan status gizi baik. Kurang zat besi, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Magnesium, kalsium, seng dan kurang serat sering terjadi pada lanjut usia.

F. Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi

1. Asupan Makanan

Asupan makanan merupakan faktor utama yang dapat menentukan gizi seseorang. Seseorang dengan status gizi baik biasanya dengan asupan makanan dengan baik pula. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan.

Status gizi kurang terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu zat esensial. Status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah berlebih, sehingga menimbulkan efek toksik atau membahayakan. Gangguan gizi disebabkan oleh faktor primer atau sekunder. Faktor primer adalah apabila susunan makanan seseorang salah dalam kuantitas dan atau kualitas yang disebabkan oleh kurangnya penyediaan pangan, kurang baiknya distribusi pangan, kemiskinan, ketidaktahuan, kebiasaan makan yang salah, dan sebagainya. Faktor sekunder meliputi semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai di sel-sel tubuh setelah makanan dikonsumsi (Almatsier, 2002).

2. Pengetahuan Gizi

Pengetahuan (knowledge) merupakan hasil dari tahu, dan itu terjadi setelah orang melakukan penginderaan suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003).

Adanya pengetahuan gizi yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang terhadap makanan. Selain itu, pengetahuan gizi mempunyai peranan penting untuk dapat membuat manusia hidup sejahtera dan berkualitas. Semakin banyak pengetahuan gizinya semakin diperhitungkan jenis dan kualitas makanan yang dipilih dikonsumsinya (Soediaoetama, 2000).

Tingkat pengetahuan gizi yang tinggi dapat membentuk sikap positif terhadap masalah gizi. Pada akhirnya pengetahuan akan mendorong untuk menyediakan makanan sehari-hari dan jumlah dan kualitas gizi yang sesuai dengan kebutuhan (Soediaoetama, 2000).

3. Penyakit infeksi

Penyakit infeksi dan demam dapat menyebabkan merosotnya nafsu makan atau menimbulkan kesulitan menelan dan pencernaan makanan, parasit dalam usus, seperti cacing gelang dan parasit cacing pita, bersaing dalam tubuh untuk memperoleh makanan sehingga menghalangi penyerapan zat gizi, keadaan ini membuat terjadinya kurang gizi (Soediaoetama, 2000).

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan status gizi lansia (Almatsier, 2010), antara lain:

1. Perubahan fisiologis

Penurunan fungsi fisiologis pada lansia merupakan hal yang terjadi secara alami seiring dengan pertambahan usia. Penurunan ini meliputi perubahan kemampuan lansia dalam merespon rangsangan dari dalam maupun luar tubuh. Perubahan fungsi anatomi dan fisiologis sistem panca indera dan system pencernaan memiliki hubungan erat dengan penurunan status gizi. Perubahan tersebut menyebabkan lansia tidak menikmati makanan dengan baik. Selain perubahan fisiologis, penggunaan gigi palsu yang tidak tepat akan memberikan rasa sakit dan kurang nyaman ketika mengunyah. Hal-hal inilah yang dapat menyebabkan asupan nutrisi berkurang sehingga berakibat pada penurunan status gizi lansia.

2. Status ekonomi

Masa pensiun yang dialami lansia akan berdampak salah satunya pada keadaan keuangan keluarga. Kondisi keuangan keluarga yang menurun secara tidak langsung berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas asupan zat gizi. Apabila hal ini berlangsung dalam waktu lama dapat mengakibatkan lansia mengalami gizi kurang.

3. Psikologis

Demensia atau orang awam menyebutnya “pikun” diderita sebagian kecil lansia di atas 65 tahun dan semakin meningkat sekitar 20% pada usia 80 tahun. Manifestasi “pikun” diantaranya disorientasi, kecemasan dan kegelisahan. Manifestasi tersebut dapat menurunkan asupan makanan dan perubahan aktivitas fisik sehingga bila berlangsung dalam jangka waktu lama akan menyebabkan penurunan status gizi.

4. Status Kesehatan

Status kesehatan dan status gizi saling berhubungan erat satu sama lain. Meningkatnya penyakit infeksi, penyakit degeneratif dan non degeneratif serta masalah kesehatan gigi-mulut merupakan bagian dari status kesehatan yang berperan dalam perubahan status gizi. Kondisi tersebut dapat mengubah cara makan sehingga mempersulit asupan nutrisi. Efek samping mengonsumsi obat-obatan sistemik mengakibatkan lansia mengalami penurunan selera makan, mulut kering, perubahan pada indera pengecap, mual dan muntah. Apabila berlangsung lama dapat menyebabkan penurunan asupan nutrisi yang pada akhirnya menyebabkan lansia kekurangan gizi.

G. Asupan Gizi Untuk Lansia

Asupan adalah jumlah zat gizi yang diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun, dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Lansia harus tetap memperhatikan asupan gizinya meskipun lansia tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan lagi. Lansia sangat membutuhkan asupan gizi zat yang esensial untuk mengganti sel-sel yang sudah rusak serta menjaga kestabilan daya tahan tubuhnya (Wirakusumah, 2000). Pada prinsipnya zat gizi dibutuhkan oleh lansia sama adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dan serat dalam jumlah seimbang yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lansia.

Konsumsi makanan yang cukup dan seimbang bermanfaat bagi lansia untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan penyakit degeneratif serta kemungkinan kurang gizi (Depkes, 2003). Menurut Adriani & wiratmadi (2012) pengaturan makan untuk usia lanjut sebagai berikut :

1. Jadwal waktu makan dibuat lebih sering dengan porsi kecil.
2. Banyak minum dan kurangi garam.
3. Membatasi asupan makanan sumber kalori untuk menjaga berat badan tetap dalam batas normal.
4. Memilih jenis makanan yang mengandung serat agar baung air besar menjadi mudah dan teratur.
5. Bagi mereka yang proses penuaannya sudah lebih lanjut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Makanlah makanan yang mudah dicerna.

- b. Hindari makanan yang terlalu manis dan gurih.
- c. Bila ada kesukaan mengunyah, makanan harus lunak/cincang.
- d. Makanan selingan diberikan pada jam 10.00 pagi dan 16.00 sore

H. Prinsip Kebutuhan Gizi Lansia

Pada prinsipnya kebutuhan gizi pada lanjut usia mengikuti prinsip gizi seimbang. Konsumsi makanan yang cukup dan seimbang bermanfaat bagi lanjut usia untuk mencegah atau mengurangi risiko penyakit degeneratif dan kekurangan gizi. Kebutuhan gizi lanjut usia dihitung secara individu (Kemenkes RI, 2012). Pesan gizi seimbang pada lanjut usia (Kemenkes RI, 2012):

1. Makanlah aneka ragam makanan

Makanan ya beraneka ragam adalah makanan yang terdiri dari minimal 4 sumber bahan makanan yaitu bahan makanan pokok, lauk-pauk, sayuran dan buah. Semakin beraneka ragam dan bervariasi jenis makanan yang dikonsumsi, semakin baik. Sayur dan buah sangat baik untuk dikonsumsi (dianjurkan 5 porsi per hari).

2. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi

Karbohidrat perlukan guna memenuhi kebutuhan energi. Bagi lanjut usia, dianjurkan untuk memilih karbohidrat kompleks seperti beras, beras merah, havermout, jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu dan umbi-umbian. Karbohidrat yang berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan utuh berfungsi sebagai sumber energy dan sumber serat. Dianjurkan agar lanjut usia mengurangi konsumsi gula sederhana seperti gula pasir dan sirup.

3. Batasi konsumsi lemak dan minyak

Bagi lanjut usia, mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi tidak dianjurkan, karena akan menambah risiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, jantung, ginjal, dan lain-lain. Sumber lemak yang baik adalah lemak tidak jenuh yang berasal dari kacang-kacangan, alpukat, minyak jagung, minyak zaitun. Lemak minyak ikan mengandung omega 3, yang dapat menurunkan kolesterol dan mencegah arthritis, sehingga baik dikonsumsi oleh lanjut usia. Lanjut usia sebaiknya mengonsumsi lemak tidak lebih dari seperempat kebutuhan energi.

4. Makanlah makanan sumber zat besi

Zat besi adalah salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Zat besi secara alamiah diperoleh dari makanan seperti daging, hati dan sayuran hijau. Kekurangan zat besi yang dikonsumsi bila berkelanjutan akan menyebabkan penyakit anemia gizi besi dengan tanda-tanda pucat, lemah, lesu, pusing, dan mata berkunang-kunang. Demikian juga pada lanjut usia, perlu mengonsumsi makanan sumber zat besi dalam jumlah cukup.

5. Biasakan makan pagi

Makan pagi secara teratur dalam jumlah cukup dapat memelihara ketahanan fisik, mempertahankan daya tahan tubuh dan meningkatkan produktifitas kerja. Lanjut usia sebaiknya membiasakan makan pagi agar selalu sehat dan produktif.

6. Minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya

Air minum yang bersih dan aman adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan telah dididihkan serta disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup. Air sangat dibutuhkan sebagai media dalam proses metabolisme tubuh. Apabila terjadi kekurangan air minum akan mengakibatkan kesadaran menurun.

7. Lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur

Agar dapat mempertahankan kebugaran, lanjut usia harus tetap berolah raga. Aktivitas fisik sangat penting peranannya bagi lansia. Dengan melakukan aktivitas fisik, maka lanjut usia dapat mempertahankan bahkan meningkatkan derajat kesehatannya. Namun, karena keterbatasan fisik yang dimilikinya perlu dilakukan penyesuaian dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari.

8. Tidak minum alkohol dan membaca label makanan

Lansia disarankan untuk tidak minum alkohol karena alkohol bagi lansia dapat meningkatkan risiko demensia atau penyakit Alzheimer menyebabkan perubahan pada jantung dan pembuluh darah. Ketika membeli makanan kemasan diharapkan dapat lebih dahulu membaca label makanan guna mengetahui bahan apa saja yang terkandung di dalam produk makanan sehingga aman dimakan lansia.

Angka kecukupan gizi yang dianjurkan adalah banyaknya tiap - tiap zat gizi esensial yang harus dipenuhi dari makanan sehari - hari untuk mencegah defisiensi zat gizi. AKG dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, aktivitas fisik dan keadaan fisiologis seperti hamil atau menyusui (Fatmah, 2010). Berikut angka kecukupan gizi pada lansia.

Tabel 4.2 Angka Kecukupan Gizi Lansia

Kelompok umur	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Korbohidrat (g)
Laki-laki				
50-64 tahun	2150	65	60	340
65-80 tahun	1800	64	50	275
Perempuan				
50-64 tahun	1800	60	50	280
65-80 tahun	1500	58	45	230

Sumber : AKG (2019)

I. Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Gizi Pada Lansia

Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi lansia dalam pemenuhan gizi adalah:

1. Usia

Seiring pertambahan usia, kebutuhan zat gizi karbohidrat dan lemak menurun, sedangkan kebutuhan protein, vitamin dan mineral meningkat. Hal ini dikarenakan ketiganya berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas (Fatmah, 2010). Semakin tinggi usia lansia maka akan semakin rentan mengalami masalah kesehatan karena adanya faktor-faktor penuaan. Beberapa penurunan fungsi yang terkait dengan proses pencernaan lansia adalah menurunnya indra pengecap dan penciuman, tanggalnya gigi, kesulitan mengunyah dan menelan, dan penurunan asam lambung (Fatmah, 2010).

2. Jenis kelamin

Umumnya laki-laki memerlukan zat gizi lebih banyak (terutama energi, protein dan lemak) dibandingkan pada wanita, karena postur, otot dan luas permukaan tubuh laki-laki lebih luas dari wanita. Namun kebutuhan zat besi (Fe) pada wanita cenderung lebih

tinggi, karena wanita mengalami menstruasi. Pada wanita yang sudah menopause kebutuhan zat besi (Fe) turun kembali (Kemenkes RI, 2012).

3. Aktivitas fisik dan pekerjaan

Lanjut usia mengalami penurunan kemampuan fisik yang berdampak pada berurangnya aktivitas fisik sehingga kebutuhan energinya juga berkurang. Kecukupan zat gizi seseorang juga sangat tergantung dari pekerjaan sehari-hari : ringan, dang, berat. Makin berat pekerjaan seseorang makin besar zat gizi yang dibutuhkan. Lanjut usia dengan pekerjaan fisik yang berat memerlukan at gizi yang lebih banyak (Kemenkes RI, 2012).

4. Postur tubuh

Postur tubuh yang lebih besar memerlukan energi lebih banyak dibandingkan postur tubuh yang lebih kecil (Kemenkes RI, 2012).

5. Kurangnya perawatan mulut

Kurangnya perawatan mulut dapat mempengaruhi lansia dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Ketidakbersihan mulut menyebabkan gigi dan gusi kerap terinfeksi, yang akan mempengaruhi lansia dalam merasakan cita rasa makanan. Faktor yang menyebabkan kurang perawatan gigi adalah tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya transportasi, kurangnya perawatan gigi dan mahalnya pelayanan perawatan gigi (Miller, 2004).

6. Gangguan fungsional dan proses penyakit

Gangguan fungsional kuat hubungannya dengan kekurangan nutrisi dan kesulitan memperoleh makanan, khususnya pada komunitas lansia (Miler, 2004). Sebanyak 85% dari lansia memiliki penyakit kronis. Akibat penyakit

kronis ini lansia mengalami keterbatasan dalam beraktivitas sehingga mempengaruhi kemampuan lansia dalam memperoleh, mempersiapkan, dan menikmati makanan. Selain itu pengaturan makanan yang lebih ketat pada penderita diabetes atau gagal jantung juga mempengaruhi selera makan pada lansia (Hiemburger, 2006).

7. Efek pengobatan

Bertambahnya usia identik dengan ketergantungan obat. Pada dasarnya, pengobatan dapat memperbaiki kondisi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup, tetapi di lain pihak pengobatan pun dapat mempengaruhi asupan kebutuhan gizi lansia. Efek ini timbul karena obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi proses penyerapan zat gizi (Wirakusumah, 2002). Selain itu, obat yang dikonsumsi dapat mengubah nafsu makan, rasa atau bau yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi ataupun memiliki efek samping seperti mual, muntah, atau diare (Heimbürger, 2006).

8. Gaya hidup

Lansia mengonsumsi obat-obatan dan alkohol efek yang terjadi yaitu menurunkan selera makan lansia, terganggunya kemampuan indra perasadan pembau, terganggunya proses pencernaan, absorbs, metabolisme, dan eksresi nutrisi, merokok, selain itu pola makan yang tidak baik dan tidak berolahraga juga sangat mempengaruhi status gizi pada lansia.

9. Faktor psikososial

Faktor psikososial dapat mempengaruhi selera dan pola makan pada lansia. Stress dan cemas dapat mempengaruhi proses sistem pencernaan melalui sistem saraf autonomi. Depresi, masalah memori dan penurunan

kognitif lainnya juga dapat mempengaruhi pola makan dan kemampuan dalam menyiapkan makanan (Miller, 2004).

10. Faktor sosial ekonomi dan budaya

Latar belakang suku, kepercayaan religius dan faktor budaya yang kuat dapat mempengaruhi seseorang dalam mendefinisikan, memilih, menyiapkan dan memakan makanan serta minuman. Faktor budaya juga dapat mempengaruhi pola makan seseorang sehingga hal ini memiliki hubungan dengan status kesehatan seseorang (Miller, 2004).

Status ekonomi yang rendah juga akan mempengaruhi lansia dalam memilih asupan dan jenis makanan yang akan dikonsumsi bahkan lansia akan memilih satu kali makan dalam sehari. Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi lansia dalam memilih makanan yang tepat untuk dikonsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi nya (Miller, 2004).

11. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi seseorang dalam menikmati makanan dan kemampuan untuk memperoleh dan mempersiapkan makanannya. Banyak hambatan diidentifikasi dalam lingkungan perawatan lansia seperti panti werdha, pelayanan sosial dan rumah sakit. Lansia yang berada di ekonomi rendah cenderung berada di rumah yang di bawah standar yang mungkin tidak memiliki perawatan untuk menyimpan dan memasak makanan. Lansia yang dirawat di rumah sakit juga akan mempengaruhi status nutrisinya. Hal ini diakibatkan karena dibatasinya asupan diet serta fasilitas dan waktu yang kurang mendukung. (Miller, 2004).

BAB 5

PENUTUP

Penulisan buku monograf ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang luas mengenai gangguan kelenturan secara umum akibat kebugaran tubuh yang tidak terjaga dari remaja sampai dampaknya pada lansia.

Tujuan penulisan buku monograf ini adalah: 1. Memberikan informasi ilmiah mengenai perilaku sehari-hari sejak usia remaja yang dapat berdampak gangguan pada lansia. Dengan menjelaskan perilaku sehari-hari dan menyampaikan contoh, diharapkan buku ini dapat memberikan rujukan pemahaman bagi pembaca. 2. Meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya melakukan aktivitas fisik sejak remaja agar tubuh tetap bugar dan terhindar dari gangguan fisik terutama gangguan kelenturan di usia lanjut (lansia). 3. Meningkatkan kesadaran pembaca akan pentingnya gizi sampai usia lanjut (lansia). Dengan pemahaman pentingnya gizi terutama gizi pada lansia agar mampu menjaga kebugaran dan mempertahankan berat badan ideal dengan melalui pengukuran indeks masa tubuh, maka meminimalkan potensi penyakit yang sudah ada untuk tidak menjadi berkembang dan yang tidak memiliki resiko penyakit akan tetap sehat. 4. Mendorong penelitian di bidang daur hidup manusia terutama lansia dan segala permasalahan terutama masalah otot dan persendian. 5. Menjadi referensi praktisi dalam memberikan informasi dan menjadikan panduan dalam menjalankan praktik klinis. 6. memberikan dukungan yang menyeluruh mengenai aktivitas fisik dan kebugaran serta pengelolaan gizi agar tubuh

tetap sehat dari gangguan penyakit dari usia remaja hingga lansia terutama kesehatan otot dan persendian secara berkelanjutan.

Melalui tujuan tersebut maka diharapkan buku monograf ini dapat memberikan gambaran serta pemahaman bagi mengembangkan pengetahuan dan praktik di bidang kesehatan serta memberikan motivasi untuk senantiasa menjaga kebugaran melalui aktivitas fisik dan manajemen gizi tubuh antara lain untuk menjaga kestabilan kekuatan otot dan persendian terutama kelenturan tubuh dari usia remaja hingga lansia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashwini A.G., Neha. M. and Lata P (2021) Relationship Between Body Mass Index and Flexibility in Young Adults. *Journal Of Pharmaceutical Research International*. 33(32A): 119-126. Journal of DOI: 10.9734/JPRI/2021/v33i32A31723
- Aujoulat, I., Dechêne, S., & Lahaye, M. (2018). Non-disease Specific Health Promotion Interventions for Chronically Ill Adolescents in Medical Settings: A Systematic Review. *Frontiers in Public Health*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00301>
- Bay, J. L., Vickers, M. H., Mora, H. A., Sloboda, D. M., & Morton, S. M. (2017). Adolescents as agents of healthful change through scientific literacy development: A school-university partnership program in New Zealand. *International Journal of STEM Education*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s40594-017-0077-0>
- Biddle, S. J. H., & Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. *British Journal of Sports Medicine*, 45(11), 886–895. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090185>
- BKKBN (2022). Manfaat stretching peregangan untuk lansia. tersedia juga dalam <https://golantang.bkkbn.go.id/manfaat-stretchingperegangan-untuk-lansia>
- BKKBN (2024) Lansia butuh teman sebaya. tersedia dalam : <https://golantang.bkkbn.go.id/lansia-butuh-teman-sebaya>

- Cattuzzo, M. T., dos Santos Henrique, R., Ré, A. H. N., de Oliveira, I. S., Melo, B. M., de Sousa Moura, M., de Araújo, R. C., & Stodden, D. (2016). Motor competence and health related physical fitness in youth: A systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 19(2), 123–129. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2014.12.004>
- Costin, A., Costin, N., Cohen, P., Eisenach, C., & Marchlinski, F. (2013). Effect of exercise on heart-rate response to mental stress in teenagers. *European Journal of Preventive Cardiology*, 20(4), 593–596. <https://doi.org/10.1177/2047487312444369>
- Dahli, M. P., Brekke, M., & Haavet, O. R. (2017). A qualitative assessment of adolescents' attitudes to health and seeking help for health-related problems. *European Journal for Person Centered Healthcare*, 5(3), 324. <https://doi.org/10.5750/ejpch.v5i3.1315>
- Efendi, C. K., & Rochmania, A. (2019). CIDERA OLAHRAGA PADA CABANG OLAHRAGA BULUTANGKIS (Studi Pada Klub Bulutangkis FIFA BC Sidoarjo). *Jurnal Prestasi Olahraga*, 082.
- Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J., & Payne, W. R. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: informing development of a conceptual model of health through sport. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 10(1), 98. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-10-98>
- Ferdiana, R. D. (2023). Sedentari behavior vs aktivitas fisik.

tersedia di
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2663/sedentary-behavior-vs-aktifitas-fisik

- Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I.-M., . . . Swain, D. P. (2011). American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. *Medicine and science in sports and exercise*, 43(7), 1334-1359.
- Hedman, L., Stridsman, C., Andersson, M., Backman, H., Jansson, S., & Rönmark, E. (2017). Population-based study shows that teenage girls with asthma had impaired health-related quality of life. *Acta Paediatrica*, 106(7), 1128–1135.
<https://doi.org/10.1111/apa.13847>
- Herting, M. M., & Chu, X. (2017). Exercise, cognition, and the adolescent brain. *Birth Defects Research*, 109(20), 1672–1679. <https://doi.org/10.1002/bdr2.1178>
- Hoeger, W., Hoeger, S., Fawson, A., & Hoeger, C. (2019). *Fitness and Wellness* (13 edition). Cengage.
- Holt, N. L., Neely, K. C., Slater, L. G., Camiré, M., Côté, J., Fraser-Thomas, J., MacDonald, D., Strachan, L., & Tamminen, K. A. (2017). A grounded theory of positive youth development through sport based on results from a qualitative meta-study. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 10(1), 1–49.

<https://doi.org/10.1080/1750984X.2016.1180704>

Hosseinkhani, Z., Hassanabadi, H.-R., Parsaeian, M., Nedjat, S., & Foroozanfar, Z. (2020). The role of mental health, academic stress, academic achievement, and physical activity on self-rated health among adolescents in Iran: A multilevel analysis. *Journal of Education and Health Promotion*, 9(1), 182. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_161_20

Indharty, R. S., Siahaan, A. M. P., Rosarina, Susanto, M., Tandean, S., & Risfandi, M. (2023). Prevention of sports-related concussion in soccer: a comprehensive review of the literature. *Annals of Medicine & Surgery*, 85(3), 365–373. <https://doi.org/10.1097/MS9.0000000000000268>

Kemenkes (2018) Aktivitas Fisik Lansia. tersedia : <https://ayosehat.kemkes.go.id/aktivitas-fisik-untuk-lansia>

Kemenkes (2020) <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/obesitas/page/3/apa-yang-dimaksud-aktivitas-fisik> (2020)

Kemenkes (2024) Pentingnya Olah Raga bagi lansia. tersedia pada : https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/3093/pentingnya-olahraga-bagi-lansia

Kosuke K and Masatoshi N. 2020. Influence oh Hight intensity 20-second Static Streching on the Flexibility dan Strength of Hamstring. *J. Sport. Sci. Med.* 19(2): 429–435.

Langton, C. E., & Berger, L. M. (2011). Family Structure and

Kebugaran Tubuh Manusia: Penting Dalam Mempertahankan Kelenturan Tubuh Lansia

- Adolescent Physical Health, Behavior, and Emotional Well-Being. *Social Service Review*, 85(3), 323–357. <https://doi.org/10.1086/661922>
- Lubans, D., Richards, J., Hillman, C., Faulkner, G., Beauchamp, M., Nilsson, M., Kelly, P., Smith, J., Raine, L., & Biddle, S. (2016). Physical Activity for Cognitive and Mental Health in Youth: A Systematic Review of Mechanisms. *Pediatrics*, 138(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2016-1642>
- Purwantini, D. & Lestariana, N.N. W., (2024). Kebugaran Fungsional pada Lanjut Usia Laki-laki dan Perempuan. Indonesian Journal of Kinanthropology (IJOK). Volume 4. Nomor 1. Januari 2024 hal. 8-14 Januari 2024 dapat di lihat di <https://doi.org/10.26740/ijok.v4n1.p8-14>. E-ISSN : 2775-2178
- Salahshuri, A., Sharifirad, G., Hassanzadeh, A., & Mostafavi, F. (2014). Physical activity patterns and its influencing factors among high school students of Izeh city: Application of some constructs of health belief model. *Journal of Education and Health Promotion*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.4103/2277-9531.127618>
- Sawyer, S. (2009). Adolescent Health. In *Paediatric Handbook* (pp. 175–186). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781444308051.ch15>
- Sawyer, S. M., Drew, S., Yeo, M. S., & Britto, M. T. (2007). Adolescents with a chronic condition: challenges living, challenges treating. *The Lancet*, 369(9571), 1481–1489. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60370-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60370-5)

Sreejisha P.K and Umme, S.S (2022) Hamstring Flexibility and its correlation with Body Composition in Children Who were active indoor during pandemic-A pilot study. *International Journal of Physical Education, Sport and Health*. Tersedia dalam DOI : <https://doi.org/10.22271/kheljournal.2022.v9.i4b.2577>

Swaminathan, S. S., Boratne, A. V., Patil, R., & Sankaran, A. (2020). Health Promoting Behavior Among School Going Adolescents in Puducherry-A Cross-Sectional Study. *Indian Journal of Community Health*, 32(3), 479–485. <https://doi.org/10.47203/IJCH.2020.v32i03.004>

Tremblay, M. S., Carson, V., Chaput, J.-P., Connor Gorber, S., Dinh, T., Duggan, M., Faulkner, G., Gray, C. E., Gruber, R., Janson, K., Janssen, I., Katzmarzyk, P. T., Kho, M. E., Latimer-Cheung, A. E., LeBlanc, C., Okely, A. D., Olds, T., Pate, R. R., Phillips, A., ... Zehr, L. (2016). Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Youth: An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 41(6 (Suppl. 3)), S311–S327. <https://doi.org/10.1139/apnm-2016-0151>

WHO (2024) <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

Yoon, J.-G., Kim, S.-H., & Rhyu, H.-S. (2017). Effects of 16-week spinning and bicycle exercise on body composition, physical fitness and blood variables of middle school students. *Journal of Exercise Rehabilitation*, 13(4), 400–404.

<https://doi.org/10.12965/jer.1735052.526>

GLOSARIUM

A

Aktivitas Fisik

Gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi, termasuk olahraga terstruktur dan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, bersepeda, atau membersihkan rumah.

Asupan Gizi

Jumlah dan jenis nutrisi yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan secara keseluruhan.

D

Daya Tahan

Kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan berlebihan.

E

Endorfin

Hormon alami dalam tubuh yang dilepaskan selama aktivitas fisik atau olahraga, membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa sakit.

G

Gaya Hidup Aktif

Pola hidup yang melibatkan aktivitas fisik secara rutin sebagai bagian dari keseharian, untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh

H

Hidrasi

Proses menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh melalui konsumsi air yang cukup, penting untuk fungsi organ tubuh yang optimal.

K

KEK: adalah kekurangan Energi Kalori

Kebersihan Pribadi

Praktik menjaga kebersihan tubuh, seperti mandi, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan gigi, untuk mencegah penyakit dan infeksi.

Kebugaran Jasmani

Kondisi fisik seseorang yang mencerminkan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien tanpa kelelahan berlebihan.

Kepercayaan Diri

Keyakinan individu terhadap kemampuan, nilai, dan potensi diri, sering kali dipengaruhi oleh pencapaian pribadi dan citra tubuh yang positif.

Kesehatan Mental

Keadaan kesejahteraan emosional dan psikologis yang memungkinkan seseorang untuk mengelola stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas.

Kesehatan Remaja

Keadaan optimal dari aspek fisik, mental, sosial, dan emosional pada individu yang berada dalam rentang usia 10–19 tahun.

M

Manajemen Stres

Strategi untuk mengelola tekanan emosional atau mental, seperti meditasi, olahraga, atau teknik relaksasi, untuk menjaga keseimbangan hidup.

P

PTM: Penyakit Tidak Menular

W

WHO : World Health Organization

PROFIL PENULIS



dr. Jacoba Nugrahaningtyas Wahjuning Utami, M. Kes. Lahir di Yogyakarta.

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 1994. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2000. Riwayat pekerjaan sebagai dosen diawali pada tahun 2014 sampai sekarang. Selain sebagai dosen penulis juga bekerja sebagai dokter di UKS SMKN 6 Yogyakarta dari tahun 1999-sekarang dan bekerja di salah satu klinik di Yogyakarta dari tahun 1999-sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Respati Yogyakarta mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Etika Profesi, Promosi Kesehatan, Komunikasi Profesional, Pemeriksaan dan Pengukuran, Psikologi Kesehatan, maupun Patologi Sistem. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, maupun melakukan pengabdian masyarakat baik tingkat lokal, nasional dan internasional maupun menulis rubrik konsultasi di koran digital di Yogyakarta Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nugrahaningtyas@respati.ac.id
Motto: "Hidup harus bisa menjadi berkat bagi diri sendiri maupun sesama"

PROFIL PENULIS



Sukmawati, S. Si. T., M. Kes., Penulis lahir di Yogyakarta. Penulis lulusan Pendidikan D III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang Jurusan Kebidanan Magelang. Lulusan D IV Bidan Pendidik di STIKes Respati Yogyakarta dan lulusan S2 Pascasarjana IKM Peminatan Kesehatan Reproduksi di Universitas Respati Indonesia Jakarta.

Saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 di Universitas Sebelas Maret di Surakarta. Penulis pernah bekerja di bangsal Anak RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta, menjadi Bidan PTT di Desa Kecil, Tanon, Kabupaten Sragen dan Bidan pelaksana RSIA Permata Bunda Yogyakarta. Mulai tahun 2006 – sekarang menjadi staf pengajar di Universitas Respati Yogyakarta. Disamping itu mulai tahun 2022 menjadi trainer di RB-NLP Yogyakarta. Pengalaman berorganisasi antara lain menjadi anggota Asosiasi Dosen Indonesia, menjadi anggota IBI dan saat ini menjadi tim teknis di PD IBI DIY. Terkait tridarma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran telah menulis beberapa buku dengan fokus materi kesehatan reproduksi dan promosi kesehatan, dalam bidang penelitian dan pengabdian telah melakukan publikasi baik nasional maupun internasional dan menjadi reviewer di beberapa OJS, telah menerbitkan beberapa HAKI dan melakukan pengabdian internasional yang melibatkan 100 lebih universitas di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sukmayogya1809@gmail.com
Motto: "Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. "

PROFIL PENULIS



Maratusholikhah Nurtyas, S.ST., M.Kes., Penulis lahir di Karanganyar tanggal 21 April 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Universitas Respati Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, pendidikan DIV pada Bidan Pendidik di Politeknik Kesehatan Kemenkes

Surakarta dan melanjutkan S2 Magister Kedokteran Keluarga Minat PDPK di Univeristas Sebelas Maret, Surakarta. Saat ini penulis menekuni bidang menulis dan tertarik mengembangkan pelayanan kebidanan komplementer. Buku ini merupakan karya ke-sembilan penulis setelah buku Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan Lanjut tahun 2022, Anatomi dan Fisiologi Kebidanan tahun 2023, Evidence Based Practice Soal Kasus Kebidanan Komunitas tahun 2023, Asuhan Kebidanan pada Kesehatan Reproduksi tahun 2023, Diagnosa Kesehatan Reproduksi pada Masa Klimakterium tahun 2023, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga tahun 2023, Gangguan Reproduksi Pada Pria Dan Wanita tahun 2024, Standart Prosedur Operasional Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan tahun 2024, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan tahun 2024, Bunga Rampai: Landasan Ilmiah Praktik Kebidanan untuk DIII Kebidanan tahun 2024. Email: maratusholikhah@respati.ac.id.

Motto: "Beradab, Berilmu, Berusaha dan Berdoa..Insyallaah Allah memberikan jalan terbaik "

SINOPSIS BUKU

Aktivitas fisik sangat dibutuhkan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan aktivitas fisik ini dari bayi baru lahir hingga usia lanjut (lansia). Aktivitas fisik untuk lansia perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lansia. Agar tetap bugar maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga asupan gizi. Asupan gizi dimulai dari usia bayi sampai lansia. Untuk menjaga kebugaran ini tentunya tidak lepas dari perilaku sehat sejak muda terutama pada usia remaja.

Remaja diharapkan menjaga kesehatan baik fisik maupun mental sehingga lansia dapat tetap bugar dan tubuh tetap lentur.

Kebiasaan yang dilakukan remaja akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang di masa lansia. Untuk itu remaja dengan perilaku sehat, seperti melakukan aktivitas fisik yang teratur serta menjaga pola makan yang seimbang dan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan gaya hidup sehat semasa hidupnya dan akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi tubuh sampai lansia.

Prinsip menjaga kesehatan pada remaja merupakan prinsip yang berkelanjutan, prinsip keseimbangan, kebutuhan spesifik dan memiliki kemajuan yang positif. Contoh kesehatan remaja yang memiliki dampak positif ke masa depan adalah menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial termasuk kesehatan reproduksi.

Apabila usia remaja telah memiliki perilaku sehat maka dampak positif akan dirasakan di usia lanjut (lansia).

Pada lansia agar tetap bugar tentunya perlu mengenal adanya perubahan pada lansia baik fisiologis, mental maupun psikologis serta perubahan biologis. Untuk itu pada lansia perlu mempertahankan status gizi agar tetap optimal sehingga masalah gizi pada lansia dapat di kurangi/diminimalkan. Dengan asupan gizi lansia yang tercukupi maka lansia dapat beraktivitas tanpa terbebani rasa tidak enak badan atau sakit.

Penulis mengharapkan buku ini menggugah keinginan pembaca untuk tetap bugar agar terhindar dari dampak gangguan kelenturan

yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan mungkin dengan gangguan kelenturan dapat menyebabkan aktivitas menjadi terhenti.

Aktivitas fisik sangat dibutuhkan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan aktivitas fisik ini dari bayi baru lahir hingga usia lanjut (lansia). Aktivitas fisik untuk lansia perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lansia. Agar tetap bugar maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga asupan gizi. Asupan gizi dimulai dari usia bayi sampai lansia. Untuk menjaga kebugaran ini tentunya tidak lepas dari perilaku sehat sejak muda terutama pada usia remaja.

Remaja diharapkan menjaga kesehatan baik fisik maupun mental sehingga lansia dapat tetap bugar dan tubuh tetap lentur. Kebiasaan yang dilakukan remaja akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang di masa lansia. Untuk itu remaja dengan perilaku sehat, seperti melakukan aktivitas fisik yang teratur serta menjaga pola makan yang seimbang dan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan gaya hidup sehat semasa hidupnya dan akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi tubuh sampai lansia.

Prinsip menjaga kesehatan pada remaja merupakan prinsip yang berkelanjutan, prinsip keseimbangan, kebutuhan spesifik dan memiliki kemajuan yang positif. Contoh kesehatan remaja yang memiliki dampak positif ke masa depan adalah menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial termasuk kesehatan reproduksi.

Apabila usia remaja telah memiliki perilaku sehat maka dampak positif akan dirasakan di usia lanjut (lansia).

Pada lansia agar tetap bugar tentunya perlu mengenal adanya perubahan ada lansia baik fisiologis, mental maupun psikologis serta perubahan biologis. Untuk itu pada lansia perlu mempertahankan status gizi agar tetap optimal sehingga masalah gizi pada lansia dapat di kurangi/diminimalkan. Dengan asupan gizi lansia yang tercukupi maka lansia dapat beraktivitas tanpa terbebani rasa tidak enak badan atau sakit.

Penulis mengharapkan buku ini menggugah keinginan pembaca untuk tetap bugar agar terhindar dari dampak gangguan kelenturan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan mungkin dengan gangguan kelenturan dapat menyebabkan aktivitas menjadi terhenti.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-67-5



9

786347

097675

